

2025-2026

3EME ANNEE MEDECINE

**CARDIO-RESPIRATOIRE
PSYCHOLOGIE MEDICALE**

QCM CORRIGÉES ET CLASSEES PAR **COURS**

I. SEMIOLOGIE	
PSYCHOLOGIE.....	
01. ASPECTS COMMUNICATIONNELS ET EXAMEN MENTAL	01
02. ENTREVUE MEDICALE.....	01
03. ANNONCE D'UNE MALADIE GRAVE	02
04. PSYCHOLOGIE DE LA DOULEUR.....	02
05. FONCTIONNEMENT DE LA PERSONNALITE	03
06. PSYCHOLOGIE DE LA PRESCRIPTION	03
07. STRESS ET MALADIES PSYCHOSOMATIQUES	04
SÉMIOLOGIE GÉNÉRALE.....	
01. SEMANTIQUE MEDICALE.....	04
02. OBSERVATION MEDICALE	05
03. BASES DU RAISONNEMENT CLINIQUE.....	05
04. ABORD ET EXAMEN CLINIQUE DU PATIENT	06
05. TROUBLES D'HYDRATATION.....	06
06. SEMIOLOGIE PONDERALE	07
SÉMIOLOGIE CARDIAQUE	
01. PERICARDITE	08
02. LES BRUITS CARDIAQUES	08
03. LES DOULEURS THORACIQUES.....	09
04. LA PRESSION ARTERIELLE.....	10
05. ECG	11
06. EXAMEN CARDIAQUE	12
07. LES SOUFFLES CARDIAQUES	13
08. L'INSUFFISANCE CARDIAQUE	14
09. SYNCOPES ET LIPOTHYMIES	14
10. SEMIOLOGIE VEINEUSE	15
11. SEMIOLOGIE ARTERIELLE	15
SÉMIOLOGIE RESPIRATOIRE :	
01. SEMIOLOGIE DE LA DYSPNEE.....	16
02. DOULEURS THORACIQUES EN PNEUMO	16
03. SEMIOLOGIE DE LA TOUX.....	17
04. EXPECTORATION/VOMIQUE.....	17
05. HEMOPTYSIE.....	18
06. DYSPHONIE	18
07. SIGNES PHYSIQUES EN PNEUMOLOGIE	19
08. SYNDROMES MEDIASTINAUX	19
09. LES SYNDROMES PULMONAIRES	20
10. SYNDROMES BRONCHIQUES.....	20
11. SYNDROMES PLEUREUX.....	20
12. PONCTION PLEURALE	21
13. ETUDE CYTOBACTERIOLOGIQUE DES SECRETIONS TRACHEOBRONCHIQUES	21

II. PHYSIOPATHOLOGIE	
01. THERMOREGULATION	22
02. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DENUTRITION	22
03. TROUBLES HYDROSODES	22
04. INSUFFISANCE CARDIAQUE	23
05. ETATS DE CHOC HYPOVOLEMIQUE	23
06. ETATS DE CHOC SEPTIQUE	24
07. ETATS DE CHOC CARDIOGENIQUE	24
08. ETATS DE CHOC ANAPHYLACTIQUE	25
09. HYPERTENSION ARTERIELLE	25
10. OAP	25
11. TROUBLES DE L'HEMATOSE.....	26
12. INSUFFISANCE RESPIRATOIRE.....	26
13. MALADIE THROMBOEMBOLIQUE	26
III. BIOCHIMIE.....	
01. BIOCHIMIE DE L'HOMME SAIN	27
02. LES DIFFERENTES ETAPES DE L'ANALYSE BIOCHIMIQUE	27
03. EXPLORATION DU METABOLISME DES LIPIDES ET DES LIPOPROTEINES THERMOGENESES	28
04. EXPLORATIONS BIOCHIMIQUES DU STRESS OXYDATIF	29
05. BIOMARQUEURS CARDIAQUES	30
06. EXPLORATIONS BIOCHIMIQUES DES LIQUIDES DE PONCTION	32
07. GAZOMETRIE/ SPIROMETRIE	33
IV. RADIOLOGIE	
01. PROPRIÉTÉS ET PRODUCTION DES RAYONS X.....	34
02. DANGERS DES EXPLORATIONS RADIOLOGIQUES ET MOYENS DE PROTECTION.....	34
03. FORMATION DE L'IMAGE RADIOLOGIQUE.....	35
04. LES ULTRASONS- L'ECHOGRAPHIE THORACIQUE	35
05. PRINCIPES PHYSIQUES DE L'IRM / IRM THORACIQUE	36
06. TDM THORACIQUE	37
07. LES PRODUITS DE CONTRASTE EN IMAGERIE	37
08. RADIOGRAPHIE STANDARD THORACIQUE ET RADIOANATOMIE NORMALE DU CŒUR	37
09. LES PRINCIPALES TECHNIQUES D'EXPLORATIONS CARDIOVASCULAIRES ET LEURS INDICATIONS	39
10. SYNDROME ALVEOLAIRE	39
11. SYNDROME MEDIASTINAL	40
12. SYNDROME PLEURAL / SYNDROME PARIETAL.....	40
13. SYNDROME BRONCHIQUE	41
14. SYNDROME CAVITAIRE	41

SEMILOGIE

1. PSYCHOLOGIE :

1. ASPECTS COMMUNICATIONNELS ET EXAMEN MENTAL (6 QCM)

1. Quels éléments sont évalués dans l'apparence du patient ?

- A. Hygiène et soins personnels.
- B. Mimique (triste, anxieuse, inexpressive).
- C. Couleur des yeux.
- D. Posture (relâchée, tendue, recroquevillée).
- E. Marque des vêtements.

Source : PROMO 2022

Réponse : ABD

2. Quels symptômes sont caractéristiques du syndrome psychotique ?

- A. Hallucinations auditives.
- B. Délire de persécution.
- C. Troubles du sommeil
- D. Désorganisation du discours.
- E. Fatigue excessive

Source : PROMO 2022

Réponse : ABD

3. L'examen mental explore :

- A. La façon d'interagir du patient
- B. Uniquement ses opinions politiques
- C. Les émotions profondes du sujet
- D. Son aspect extérieur
- E. Les idées suicidaires

Source : PROMO 2021

Réponse : ACDE

4. L'évaluation de l'état mental devra aborder les aspects cognitifs suivants :

- A. La conscience et la mémoire.
- B. La personnalité.
- C. Le jugement et autocritique.
- D. Le regard.
- E. La qualité du sommeil.

Source : PROMO 2020

Réponse : ABC

5. L'intelligence émotionnelle est caractérisée par :

- A. La connaissance des émotions.
- B. La maîtrise des émotions.
- C. L'auto-motivation.
- D. La non-perception des émotions d'autrui
- E. L'incompétence sociale.

Source : PROMO 2019

Réponse : ABC

6. Le cerveau limbique est :

- A. Est le cerveau de la créativité
- B. Il représente le raisonnement, la déduction et la logique
- C. C'est le centre des émotions
- D. Il contient l'amygdale
- E. Possède un rôle important dans la mémoire et l'apprentissage

Source : PROMO 2018

Réponse : CDE

2. ENTREVUE MEDICALE (4 QCM)

1. Les renseignements recueillis au cours de l'entrevue médicale servent à :

- A. Définir Le motif de la consultation.
- B. Cerner toutes les informations sans analyse objective.
- C. Etablir avec certitude un seul diagnostic.
- D. Diriger l'examen physique.
- E. Guider le type d'examens complémentaires à demander.

Source : PROMO 2022

Réponse : ADE

2. Quelles sont les propositions exactes concernant les problèmes qui peuvent être rencontrés au cours d'une entrevue médicale ?

- A. Problèmes Liés toujours au malade.
- B. Problèmes liés à l'entourage.
- C. Problèmes Liés au médecin.
- D. Problèmes liés à la langue.
- E. Problèmes ne pouvant être en rapport avec une situation particulière (urgences, sujet âgé, pathologie mentale).

Source : PROMO 2022

Réponse : BCD

3. L'attitude du médecin au cours de l'entrevue médicale devra respecter les éléments suivants :

- A. Écoute active
- B. Prendre en considération une partie des problèmes du patient
- C. Inviter systématiquement les proches du patient à assister à la consultation
- D. Porter un jugement sur le patient
- E. Adopter une attitude éthique et preuve de respect.

Source : PROMO 2021

Réponse : AE

4. Les problèmes rencontrés au cours d'une entrevue médicale sont :

- A. Liés uniquement au malade.
- B. Liés toujours au médecin.
- C. Peuvent être liés à l'entourage
- D. Peuvent être liés à un problème de langue.
- E. Peuvent être en rapport avec des situations particulières (urgences, sujet âgé, pathologie mentale).

Source : PROMO 2019

Réponse : CDE

3. ANNONCE D'UNE MALADIE GRAVE (6 QCM)

1. Quelles sont les erreurs que le médecin doit éviter lors de l'annonce d'une maladie grave ?

- A. La dilution des responsabilités
- B. L'incohérence des messages transmis
- C. Le retard à l'information
- D. L'utilisation d'un vocabulaire clair
- E. Rappeler les résultats des examens complémentaires pratiqués

Source : PROMO 2022

Réponse : ABC

2. A propos des maladies graves :

- A. Certaines maladies chroniques ne sont pas des maladies graves.
- B. Une maladie grave est : un état de santé où la mort est possible ou imminente.
- C. Les maladies graves sont responsables de 80 % des décès prématurés dans le monde.
- D. Une maladie grave est toujours chronique.
- E. Les affections de longue durée évoluent lentement.

Source : PROMO 2022

Réponse : ABCE

3. Concernant les mécanismes de défense chez le patient lors de l'annonce d'une maladie grave :

- A. Le mensonge
- B. La projection agressive
- C. Le déni
- D. La régression
- E. L'acceptation

Source : PROMO 2021

Réponse : BCD

4. Pour annoncer une maladie grave à un patient, quelle est parmi les propositions suivantes la plus appropriée :

- A. L'annonce peut se faire pendant une conversation téléphonique avec le patient.
- B. Bureau dédié à cette consultation où aucune personne non concernée n'est présente.
- C. On accepte la présence de plusieurs professionnels de santé au bureau lors de l'annonce.
- D. Le médecin peut regarder sa montre ou répondre à un appel téléphonique au moment de l'annonce.
- E. Temps consacré à cette consultation est de brève durée.

Source : PROMO 2020

Réponse : B

5. Pour préparer le patient à une annonce d'une maladie grave, Il faudra :

- A. La présence maximale de deux professionnels de santé.
- B. Faire l'annonce par téléphone.
- C. Consacre un temps limite moins de 30 minutes.
- D. Un endroit calme où le patient sera confortablement installé.
- E. Avoir une stratégie de prise en charge après l'annonce.

Source : P 2019 / P 2018

Réponse : ADE

6. Au moment de l'annonce d'une maladie grave, le médecin doit :

- A. Eviter de regarder au patient
- B. Exprimer un manque de disponibilité.
- C. Utiliser des termes trop techniques
- D. Accepter la présence de plusieurs membres de la famille.
- E. Avoir une attention et le temps nécessaire pour le patient.

Source : RATRAPAGE 2022

Réponse : E

4. PSYCHOLOGIE DE LA DOULEUR (4 QCM)

1. Quels sont les éléments qui peuvent constituer la composante psychique de la douleur

- A. Le contexte socio-économique
- B. Le contexte affectivo-emotionnel
- C. Le caractère chronique
- D. La mauvaise compréhension de la douleur
- E. La composante comportementale.

Source : PROMO 2021

Réponse : ABCE

2. La perception psychique de la douleur diffère selon les facteurs suivants :

- A. Certains types de douleur peuvent engendrer des réactions émotionnelles inappropriées.
- B. Une douleur brutale et intense peut être alarmante et entraîner une réaction surdimensionnée.
- C. Les sujets âgés ne réagissent pas à la douleur.
- D. Certaines personnalités anxieuses répondent avec une surcharge émotionnelle à une douleur.
- E. Les personnes narcissiques ne réagissent pas à la douleur.

Source : PROMO 2019**Réponse : ABD****3. Quels sont les éléments qui conditionnent le succès des traitements de la douleur chronique ?**

- A. Comprendre la nature de la douleur et accepter la réalité de la douleur
- B. Il faut admettre la douleur dans son ensemble sans prendre en considération le côté psychologique pour lutter contre la douleur.
- C. Il faut une nette adhésion aux traitements prescrits contre la douleur
- D. Il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul processus qui peut expliquer l'entretien et l'amplification de la douleur
- E. Le traitement antidouleur fait appel exclusivement aux médicaments anti-douleur.

Source : PROMO 2018**Réponse : AC****4. Les facteurs de la perception psychique de la douleur sont :**

- A. Le type de la douleur et les organes cibles .
- B. Les sujets jeunes réagissent de manière exagérée à la douleur.
- C. Les psychopathes et particulièrement les schizophrènes réagissent de manière exagérée à la douleur.
- D. Les dépressifs réagissent intensément à la douleur
- E. Les hypochondriaques réagissent de manière exagérée à la douleur

Source : PROMO 2018**Réponse : ADE**

5. FONCTIONNEMENT DE LA PERSONNALITE (4 QCM)

1. Les personnalités psychotiques comportent :

- A. La personnalité schizotypique
- B. La personnalité paranoïaque
- C. La personnalité limite
- D. La personnalité schizoïde
- E. La personnalité narcissique.

Source : PROMO 2021**Réponse : ABD****2. La personnalité obsessionnelle est caractérisée par :**

- A. Un intérêt pour l'ordre et le rangement
- B. Un laxisme
- C. Un autoritarisme
- D. Une froideur affective
- E. Un manque de sérieux dans tous les domaines.

Source : PROMO 2021**Réponse : ACD****3. La personnalité limite est caractérisée par :**

- A. Une pauvreté des affects.
- B. Un sentiment de vide.
- C. Une envie et Jalousie pour les autres.
- D. Une angoisse diffuse.
- E. Un idéal de vie irréaliste.

Source : PROMO 2020**Réponse : BD****4. Les traits de personnalité histrionique comportent :**

- A. Une avidité affective.
- B. Un théâtralisme.
- C. Un besoin d'être pris en charge et accompagné dans ses décisions.
- D. Une frigidity ou impuissance.
- E. Un sentiment de vide permanent.

Source : PROMO 2019**Réponse : ABD**

6. PSYCHOLOGIE DE LA PRESCRIPTION (2 QCM)

1. L'Observance est plus facilement obtenue si :

- A. La maladie est perçue comme étant sévère
- B. Le médicament a beaucoup d'effets secondaires
- C. L'entourage du malade est compréhensif et facilitant
- D. Le patient exprime son déni vis-à-vis sa maladie
- E. Le traitement instauré est efficace.

Source : P 2021 / P 2019**Réponse : ACE****2. Quelles sont les propositions exactes concernant la prescription médicale ?**

- A. Permet d'établir un lien entre le médecin et son patient.
- B. Elle n'affirme pas le caractère pathologique de l'affection.
- C. Elle est faite uniquement sur la délivrance d'une ordonnance pour prise médicamenteuse.
- D. Elle doit être personnalisée en cas de pathologie chronique.
- E. Elle ne nécessite pas la vérification de l'observance.

Source : PROMO 2020**Réponse : AD**

7. STRESS ET MALADIES PSYCHOSOMATIQUES (6 QCM)

1. Les manifestations de la Maladie Psychosomatique sont :

- A. Rougeurs, pâleurs, palpitations, névralgies d'allure angineuse, hypotension
- B. L'ulcère gastrique
- C. Le prurit, certaines urticaires, certaines chutes de cheveux, l'acné
- D. Certaines dysuries, brulures mictionnelles, pollakiurie, énurésie ...
- E. Retard staturopondéral

Source : PROMO 2022

Réponse : ABCD

2. Le stress est

- A. Une réaction d'adaptation naturelle face à un événement
- B. Une réaction d'adaptation non naturelle face à un événement
- C. Contagieux
- D. Une maladie organique non curable
- E. Bénéfique pour la santé.

Source : PROMO 2021

Réponse : A

3. La maladie psycho somatique se manifeste sur le plan cardio-vasculaire par :

- A. Disparition des poulx.
- B. Des sensations vertigineuses.
- C. Des céphalées de tension.
- D. Des douleurs précordiales.
- E. Des épisodes de baisse de la pression artérielle.

Source : PROMO 2020

Réponse : DE

4. Les facteurs de stress de l'environnement sont dus aux :

- A. Les conditions familiales.
- B. Le bruit et la sursimulation.
- C. Relations sociales et les conflits.
- D. Absence d'objectifs.
- E. Faible estime et insécurité de soi.

Source : PROMO 2020

Réponse : ABC

5. Le champ psychosomatique recouvre les aspects suivants :

- A. Les maladies psychosomatiques.
- B. Troubles fonctionnels.
- C. Alexithymie.
- D. Syndromes paranéoplasiques,
- E. Insuffisance rénale chronique.

Source : PROMO 2019

Réponse : ABC

6. Les facteurs de stress de l'environnement sont dus à :

- A. Les conditions familiales
- B. Le bruit et la sur-stimulation
- C. Relations sociales, les conflits
- D. Absence d'objectifs
- E. Faible estime et insécurité

Source : PROMO 2018

Réponse : ABC

2. SÉMIOLOGIE GÉNÉRALE :

1. SEMANTIQUE MEDICALE (7 QCM)

1. Un jeune homme de 18 ans se présente à votre consultation : il signale des vomissements et une fatigue générale. Il est fébrile (température : 38.8 degrés), l'examen de l'abdomen déclenche une douleur de la fosse iliaque droite. Il s'agit de :

- A. Signes physiques
- B. Signes physiques, généraux et fonctionnels
- C. Signes généraux et fonctionnels
- D. Signes physiques et généraux
- E. Signes fonctionnels.

Source : PROMO 2021

Réponse : B

2. Une dame de 56 ans, pesant 72 kg, présente une température de 39 degrés. Elle signale également des maux de tête et des douleurs articulaires. Il s'agit de :

- A. Signes fonctionnels
- B. Signes physiques et fonctionnels
- C. Signes généraux
- D. Signes généraux et fonctionnels
- E. Signes physiques

Source : PROMO 2021

Réponse : D

3. Une vieille dame de 68 ans, présente et une température de 38.8 degrés, une fatigue générale et des vomissements. L'examen de l'abdomen retrouve une douleur de la fosse iliaque droite. Il s'agit de :

- A. Signes physiques
- B. Signes généraux
- C. Signes physiques et généraux
- D. Signes physiques, généraux et fonctionnels.
- E. Signes physiques et fonctionnels

Source : PROMO 2020

Réponse : D

4. Un monsieur de 66 ans, pesant 72 kg présente une température de 39 degré et signale des douleurs aux membres inférieurs. Il s'agit de :

- A. Signes fonctionnels.
- B. Signes et physiques et fonctionnels
- C. Signes généraux et fonctionnels
- D. Signes généraux
- E. Signes physiques

Source : PROMO 2019

Réponse : C

5. Cochez parmi les éléments énumérés ci-dessous ceux qui correspondent à des signes fonctionnels :

- A. Palpitations
- B. Souffle cardiaque
- C. Dyspnée
- D. Choc de pointe
- E. Douleur thoracique

Source : PROMO 2018

Réponse : ACE

6. Parmi les signes cliniques suivants, cochez ceux qui correspondent à des signes généraux :

- A. Céphalées, vomissements, trouble du rythme.
- B. douleurs abdominales, céphalées
- C. œdèmes des membres inférieurs, pouls 95 pulsations/mn.
- D. température 38,5°, tension artérielle 120/60 mm Hg, pouls 95 pulsations/mn.
- E. des œdèmes des membres inférieurs, trouble du rythme cardiaque

Source : PROMO 2018

Réponse : D

7. Une vieille dame de 78 ans, présente des vomissements, à l'examen de l'abdomen une douleur de la fosse iliaque droite, une température de 38.8 degrés et une fatigue générale. Il s'agit de :

- A. Signes physiques
- B. Signes généraux
- C. Signes physiques et généraux
- D. Signes physiques, généraux et fonctionnels.
- E. Signes physiques et fonctionnels

Source : RATRAPAGE 2022

Réponse : D

2. OBSERVATION MEDICALE (1 QCM)

1. Quelles sont les propositions exactes concernant l'observation médicale ?

- A L'observation est partie intégrante du dossier médical.
- B. L'observation n'est pas évolutive.
- C. L'observation doit être protégée par le secret médical.
- D. L'observation médicale est à la portée de la famille du patient.
- E. L'observation est un dossier administratif.

Source : P 2020 / P 2019

Réponse : AC

3. BASES DU RAISONNEMENT CLINIQUE (4 QCM)

1. Les objectifs du raisonnement clinique doivent passer par :

- A. L'analyse des données de l'anamnèse et de l'examen physique
- B. L'analyse des données de l'examen physique uniquement.
- C. Le regroupement des données exclusivement sous forme de syndromes.
- D. L'élaboration d'une seule hypothèse diagnostique.
- E. L'introduction de la notion d'hierarchisation des examens complémentaires dans la démarche diagnostique

Source : P 2022 / P 2020

Réponse : AE

2. Quels sont les propositions justes concernant le raisonnement clinique ?

- A. Établir l'hypothèse diagnostic
- B. Discuter les diagnostics différentiels
- C. Poser un diagnostic de certitude
- D. Ne pas prendre en considération le pronostic
- E. Un recours systématique aux examens complémentaires.

Source : PROMO 2021

Réponse : AB

3. Quels sont les propositions qui peuvent influencer le raisonnement clinique ?

- A. L'expérience du médecin.
- B. L'âge du patient.
- C. Le degré d'urgence est sans influence.
- D. Le niveau intellectuel du patient est sans importance.
- E. La disponibilité des test diagnostiques.

Source : PROMO 2020

Réponse : ABE

4. Le raisonnement clinique peut se construire sur les modèles suivants :

- A. Un processus non analytique ou inductif
- B. Un processus analytique
- C. Une utilisation exclusive de scores de risques
- D. Un regroupement de données sous forme de syndrome
- E. Un recours systématique aux examens complémentaires.

Source : PROMO 2019

Réponse : ABD

4. ABORD ET EXAMEN CLINIQUE DU PATIENT (5 QCM)

1. Quels principes sont essentiels pour une communication efficace avec le patient ?

- A. Écoute active.
- B. Empathie.
- C. Utilisation d'un jargon médical complexe.
- D. Respect et non-jugement.
- E. Ignorer les émotions du patient

Source : PROMO 2022

Réponse : ABD

2. Les bases d'une relation médecin malade sont (qu'un médecin doit respecter) :

- A. Une relation basée sur la sympathie
- B. Une relation basée sur l'empathie
- C. Une relation basée sur la compassion
- D. Le respect des règles de déontologie
- E. Le respect des règles d'éthique.

Source : PROMO 2021

Réponse : BDE

3. Quelles sont la ou les propositions exactes concernant la relation médecin-Patient ?

- A. L'approche du patient doit considérer le vécu et l'expérience du patient
- B. La relation ne doit jamais être initiée par le malade.
- C. La relation est symétrique, et égale entre médecin et malade.
- D. La communication est exclusivement verbale
- E. Le médecin doit se concentrer sur l'entourage du patient.

Source : PROMO 2020

Réponse : A

5. Au cours de l'interrogatoire. L'écoute active du patient nécessite de :

- A. Manifester de l'intérêt.
- B. Ne pas prendre en compte des émotions
- C. Manifester de l'empathie
- D. Synthétiser les plaintes du patient
- E. N'observer que le langage verbal

Source : PROMO 2019

Réponse : ACD

4. A propos de la relation médecin - patient, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Elle est toujours initiée par le médecin.
- B. C'est une relation symétrique, égale dans les différents modèles de cette relation,
- C. La parole est l'unique moyen de communication entre le médecin et le patient
- D. L'approche du patient doit être globale, considérant entre autres l'expérience du patient
- E. La posture, la gestuelle et le regard du médecin sont des éléments importants à considérer dans une entrevue médicale

Source : P 2019 / P 2018

Réponse : DE

5. TROUBLES D'HYDRATATION (6 QCM)

1. A propos de l'hydratation intracellulaire :

- A. L'hydratation intracellulaire est sous dépendance de la pression hydrostatique
- B. L'hydratation intracellulaire est sous dépendance de la pression oncotique
- C. L'hydratation intracellulaire est sous dépendance de l'osmolalité extracellulaire
- D. L'hydratation intracellulaire est sous dépendance de la pression osmotique
- E. L'hydratation intracellulaire est sous dépendance de la pression capillaire

Source : PROMO 2022

Réponse : CD

2. Les œdèmes rénaux sont :

- A. Rouges
- B. Blancs
- C. Mous
- D. Ne prennent pas le godet
- E. Indolores

Source : PROMO 2022

Réponse : BCE

3. Les signes cliniques de la déshydratation extracellulaire :

- A. Le syndrome œdémateux
- B. La soif
- C. Sécheresse des muqueuses
- D. Le pli cutané
- E. Hypotonie des globes oculaires.

Source : P 21 / P 20 / P 19 / P 18

Réponse : DE

4. Concernant le bilan de l'eau corporel :

- A. Les sorties sont essentiellement régulées par les appareils digestifs, cutané et respiratoire
- B. Les entrées sont régulées par la soif
- C. La volémie, la tension artérielle et l'osmolarité plasmatique influent sur les entrées d'eau
- D. Un bilan nul signifie qu'il n'y a ni entrée ni sortie d'eau
- E. La réabsorption de l'eau est sous la dépendance de l'hormone anti-diurétique.

Source : PROMO 2021**Réponse : BCE****5. A propos de l'hydratation intracellulaire est sous la dépendance de :**

- A. la pression hydrostatique
- B. la pression oncotique
- C. L'osmolalité extracellulaire
- D. la pression osmotique
- E. la pression capillaire

Source : PROMO 2018**Réponse : C****6. A propos du bilan de l'eau corporelle :**

- A. Les sorties sont essentiellement régulées par les appareils digestifs, cutané et respiratoire
- B. les entrées sont régulées par la soif
- C. La volémie, la tension artérielle et l'osmolalité plasmatique influent sur les entrées d'eau
- D. Un bilan nul signifie que y'a ni entrée ni sortie d'eau
- E. La réabsorption de l'eau est sous la dépendance de l'hormone antidiurétique

Source : PROMO 2018**Réponse : BCE**

6. SEMIOLOGIE PONDERALE (8 QCM)

1. Quel type d'obésité est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète

- A. Obésité gynoïde
- B. Obésité androïde
- C. Obésité mixte
- D. Obésité cushingoïde
- E. Obésité essentielle

Source : PROMO 2022**Réponse : B****2. Quels sont les signes cliniques pouvant être observés lors de l'examen d'un patient obèse ?**

- A. Vergetures
- B. Cellulite (peau d'orange)
- C. Augmentation de la masse musculaire
- D. Diminution du périmètre abdominal
- E. Amyotrophie généralisée

Source : PROMO 2022**Réponse : AB****3. Melle Aicha âgée de 24 ans, sa taille est de 1,62 m, son poids est de 74 kg. Vous calculez son Indice de masse corporelle (IMC) qui vous permet de définir :**

- A. Une obésité sévère
- B. Une maigreur
- C. Une obésité modérée
- D. Un IMC normal
- E. Une surcharge pondérale.

Source : PROMO 2021**Réponse : E****4. Madame Nadia est âgée de 34 ans, sa taille est de 1,60 m, son poids est de 85 kg. Vous calculez son Indice de masse corporelle (IMC) qui vous permet de définir :**

- A. Une obésité sévère.
- B. Une maigreur.
- C. Une obésité modérée.
- D. Un IMC normal.
- E. Une surcharge pondérale

Source : PROMO 2020**Réponse : C****5. Le calcul de l'obésité abdominale se fait par :**

- A. L'indice de masse corporelle.
- B. Le Tour de taille.
- C. Le tour de hanches.
- D. Le poids.
- E. La taille.

Source : PROMO 2020**Réponse : B****6. Melle Karima est âgée de 24 ans, sa taille est de 1,60m, son poids est de 70 kg. Vous calculez son indice de masse corporelle (IMC), qui vous permet de définir :**

- A. Une obésité sévère
- B. Une maigreur
- C. Une obésité modérée
- D. Un IMC normal
- E. Une surcharge pondérale

Source : PROMO 2019**Réponse : E****7. L'indice de masse corporelle (IMC) :**

- A. Permet une estimation directe de l'adiposité
- B. une excellente corrélation avec la masse grasse
- C. Est appelé aussi Indice de Quételet
- D. Permet la mesure directe de la masse grasse
- E. Ne s'applique que chez l'adulte

Source : PROMO 2018**Réponse : ABCE**

8. Madame Nadia est Age de 44 ans, sa taille est de 1,72 m, son poids est de 82 kg. Vous calculez sans Indice de masse corporelle (IMC) qui vous permet de définir:

- A. Une obésité sévère
- B. Une maigreur
- C. Une obésité modérée
- D. Un IMC normal
- E. Une surcharge pondérale

Source : PROMO 2018

Réponse : E

3. SEMIOLOGIE CARDIAQUE :

1. PERICARDITE (5QCM)

1. L'auscultation cardiaque au cours d'une péricardite de moyenne abondance peut retrouver:

- A. Un assourdissement des bruits cardiaques
- B. Un frottement systolo-diastolique
- C. Une auscultation normale
- D. Un souffle holosystolique au foyer mitral
- E. Un éclat de B2 au foyer aortique

Source : PROMO 2022

Réponse : ABC

2. au cours d'une tamponnade, le pouls paradoxal de Kussmaul correspond à :

- A. Un pincement de la différentielle (Pression artérielle)
- B. Un élargissement de la différentielle
- C. Une baisse de la pression artérielle systolique à l'inspiration
- D. Une baisse de la pression artérielle diastolique à l'expiration
- E. Une anisotension (différence de pression artérielle entre le bras droit et gauche)

Source : PROMO 2022

Réponse : C

3. Concernant la douleur de la péricardite aiguë :

- A. Elle est majorée en décubitus et par la toux
- B. Elle est résistante à la trinitrine
- C. L'ECG peut montrer des modifications du segment ST et de l'onde T
- D. Elle peut s'accompagner à l'auscultation d'une vibration
- E. Elle peut s'accompagner d'un frottement péricardique.

Source : P 2021 / P 2018

Réponse : ABCE

4. Les caractéristiques de la douleur thoracique au cours des péricardites aiguës :

- A. Soulagée par la position penchée en avant.
- B. La position de décubitus dorsale aggrave la douleur.
- C. Le début est progressif.
- D. Peut persister plusieurs jours.
- E. Survient le plus souvent la deuxième moitié de la nuit.

Source : PROMO 2020

Réponse : ABD

5. Enumérer Les caractéristiques de la douleur thoracique au cours des péricardites aiguës :

- A. Douleur soulagée par la position penchée en avant
- B. Douleur aggravée par la position en décubitus dorsal.
- C. Le début est progressif
- D. Peut persister plusieurs jours
- E. Survient le plus souvent la deuxième moitié de la nuit.

Source : PROMO 2019

Réponse : ABD

2. LES BRUITS CARDIAQUES (7 QCM)

1. Lors de l'auscultation cardiaque, le foyer d'ERB est situé :

- A. Au 4ème espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure
- B. Au 2ème espace intercostal parasternal droit
- C. Au 2ème espace intercostal parasternal gauche
- D. Au 3ème espace intercostal parasternal gauche
- E. En regard de l'appendice xiphoïde

Source : PROMO 2022

Réponse : D

2. Le bruit de galop (B3) :

- A. Est un bruit surajouté
- B. Survient en diastole
- C. Est un signe d'insuffisance cardiaque
- D. Peut-être physiologique
- E. Survient en systole

Source : PROMO 2022

Réponse : ABCD

3. Parmi les bruits cardiaques systoliques on retrouve :

- A. Le « GALOP »
- B. Le « click éjectionnel »
- C. Le « click tricuspide »
- D. Le « click mitral »
- E. Le « Pistol shot »

Source : PROMO 2022

Réponse : BDE

4. Concernant le 1er bruit cardiaque B1 :

- A. Est d'intensité maximale à la base
- B. Marque le début de la diastole ventriculaire
- C. Est de timbre « sec et aigu »
- D. Correspond à la fermeture de la valve mitrale puis tricuspidale
- E. Disparaît en position debout.

Source : P 2021 / P 2020**Réponse : D****5. Cochez les réponses justes parmi les propositions suivantes concernant les bruits cardiaques :**

- A. Le B1 correspond à l'ouverture des valves aortiques et pulmonaires
- B. La perception du pouls radial correspond à l'auscultation du B2
- C. La systole débute après le B1
- D. Le bruit surajouté protodiastolique est appelé claquement d'ouverture de la mitrale
- E. L'abolition de B2 associé à un souffle systolique au 2^{ème} espace intercostal droit est retrouvé au cours de la sténose aortique.

Source : PROMO 2019**Réponse : CDE****6. A propos des bruits cardiaques :**

- A. Le B1 correspond à l'ouverture des valves aortique et pulmonaire
- B. L'abolition de B2 associée à un souffle systolique au 2^{ème} espace intercostal droit traduit un rétrécissement aortique
- C. La perception du pouls radial correspond à l'auscultation au B1
- D. La diastole débute après le B1
- E. Le bruit surajouté protodiastolique est appelé claquement d'ouverture de la mitrale

Source : PROMO 2018**Réponse : BCE****7. Le rétrécissement mitral se traduit à l'auscultation par :**

- A. Un dédoublement de B2
- B. Une diminution ou une abolition de B1
- C. Un souffle holosystolique de régurgitation au 4^{ème} espace intercostal gauche
- D. Un bruit surajouté survenant après le B2
- E. Un souffle de remplissage ventriculaire survenant après l'ouverture de la valve mitrale

Source : PROMO 2018**Réponse : DE****3. LES DOULEURS THORACIQUES (9 QCM)****1. Une douleur thoracique typique au cours d'un syndrome coronarien aigu est :**

- A. Basithoracique en coup de poignard
- B. Retro sternale, constrictive en étau
- C. Irradie vers le bras gauche et la mâchoire
- D. Cède au repos ou à la prise de trinitrine
- E. Aggravée par l'antéflexion du tronc

Source : PROMO 2022**Réponse : BC****2. En postpartum, une douleur thoracique associée à une dyspnée aiguë évoque a priori :**

- A. Une dissection aortique
- B. Un pneumothorax suffoquant
- C. Une embolie pulmonaire
- D. Une pleurésie
- E. Un zona intercostal

Source : PROMO 2022**Réponse : C****3. Devant une douleur thoracique chez une femme qui vient consulter aux urgences, vous suspectez une embolie pulmonaire, que faut-il chercher à l'interrogatoire :**

- A. Notion d'un syndrome grippal dans les semaines précédentes
- B. Terrain athéromateux (patient qui cumule des facteurs de risque cardio-vasculaire comme le diabète tabac...)
- C. Notion de chirurgie pelvienne ou digestive récente
- D. Accouchement récent
- E. Notion d'œdème du mollet unilatéral en rapport avec une thrombose veineuse profonde.

Source : P 2021 / P 2018**Réponse : CDE****4. La douleur typique au cours de l'infarctus du myocarde est :**

- A. type de déchirement irradiant souvent dans le dos et les lombes.
- B. Basithoracique, brutale a type de coup de poignard.
- C. Augmentée par l'inspiration et la toux, et diminuée par l'antéflexion du tronc.
- D. A type de crampe rythmée par les repas.
- E. Medio thoracique, constructive pouvant Irradier vers le bras gauche.

Source : PROMO 2020**Réponse : E**

5. Une douleur thoracique peut orienter vers une origine coronarienne lorsqu'elle :

- A. Survient à l'effort.
- B. Soulagée par le changement de position.
- C. De siège rétrosternal
- D. Irradie vers l'épaule gauche.
- E. Déclenchée par l'inspiration profonde.

Source : PROMO 2020**Réponse : ACD****6. Une douleur thoracique peut orienter vers une origine coronarienne lorsqu'elle :**

- A. Survient toujours à l'effort
- B. De type de constriction ou de brûlure.
- C. De siège rétrosternal.
- D. Irradie vers l'épaule droite.
- E. Déclenchée par l'inspiration profonde.

Source : PROMO 2019**Réponse : BC****7. Quelles sont parmi les proposition suivantes, celles retrouvés dans le syndrome coronarien aigu**

- A. Douleur constrictive medio thoracique.
- B. Améliorer par les changements de positions.
- C. Peut Irradier au dos.
- D. Durée supérieure à 10 minutes,
- E. Ne cède pas à la trinitrine.

Source : PROMO 2019**Réponse : ACE****8. A propos des douleurs thoraciques aiguës :**

- A. Plus elles sont intenses, plus la pathologie sous-jacente est grave et urgente.
- B. Leur origine est toujours cardiaque.
- C. Leur caractère rythme ou non par la respiration oriente le diagnostic étiologique
- D. Elles sont pariétales lorsque provoquées par la palpation du grill costal.
- E. Peuvent parfois être provoquées par une pathologie digestive.

Source : PROMO 2018**Réponse : ACDE****9. Quelle complication avec douleur d'origine cardiaque peut se voir chez une patiente présentant une thrombose veineuse des membres inférieurs ?**

- A. Un Infarctus du myocarde
- B. Une péricardite
- C. Une Dissection aortique
- D. Un trouble du rythme.
- E. Une Embolie pulmonaire

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : E****4. LA PRESSION ARTERIELLE (9 QCM)****1. la mesure de la pression artérielle :**

- A. le brassard doit être de taille adaptée à la corpulence du patient
- B. la hauteur du brassard doit être équivalente à 20% de longueur du bras
- C. La poche gonflable doit couvrir 80% de la circonférence du bras
- D. la poche gonflable doit idéalement se trouver sur le trajet de l'artère radiale
- E. la poche gonflable doit idéalement se trouver sur le trajet de l'artère humérale

Source : PROMO 2022**Réponse : ACE****2. Les conditions pour mesurer la pression artérielle au cabinet sont :**

- A. Prise en position debout
- B. Apres 10 min de repos
- C. Le respect d'un minimum de 5 min après un repas
- D. Au moins 4 mesures à 5 min d'intervalle lors de la même consultation
- E. A mesurer dans les deux bras

Source : PROMO 2022**Réponse : BE****3. Pour dépister une HTA :**

- A. Un seul chiffre élevé trouver au cabinet médical suffit pour poser le diagnostic
- B. On peut utiliser soit l'automesure ou la MAPA
- C. La mesure de la PA doit s'effectuer sur un seul bras pour dépister l'anisotension
- D. L'HTA des blouses blanches correspond a des chiffres élever a domicile et normal au cabinet
- E. L'HTA masqué correspond à des chiffres normal domicile et élevé au cabinet.

Source : PROMO 2021**Réponse : B****4. Quels sont les seuils de définition de l'hypertension artérielle en ambulatoire par automesure à domicile ?**

- A. 135 et/ou 85 mm hg.
- B. 130 et/ou 80 mm hg.
- C. 140 et/ou 90 mm hg
- D. 120 et ou 70 mm hg.
- E. 130 et/ou 85 mm hg.

Source : PROMO 2020**Réponse : A**

5. Quels sont les règles de bonne prise de la tension artérielle au cabinet médical ?

- A. Période de repos non obligatoire.
- B. Brassard adapté à la circonférence du Bras
- C. Port de vêtements serrés permis.
- D. Une seule prise tensionnelle est suffisante.
- E. La position du bras au même niveau du cœur.

Source : PROMO 2020**Réponse : BE****6. La mesure de la pression artérielle au cabinet médical nécessite le respect des modalités suivantes :**

- A. Mesure de la PA sans prendre en considération la prise d'un repas, un exercice physique ou le tabac
- B. Patient assis pendant plusieurs minutes dans une pièce calme.
- C. Brassard & hauteur du cœur.
- D. Le stéthoscope doit être posé sur l'artère brachiale sans toucher le brassard.
- E. Dégonfler le brassard progressivement à raison de 5 mm / seconde

Source : PROMO 2019**Réponse : BCD****7. Selon l'ESH-ESC, une HTA de grade 2 se définit par des chiffres de pression artérielle :**

- A. PAS systolique (PAS) comprise entre 130-139 mm Hg; PA diastolique (PAD) entre 90-99 mm hg
- B. PAS comprise entre 145-159 mm Hg; PAD entre 95-99 mm Hg
- C. PAS comprise entre 160-169 mm Hg; PAD entre 95-100 mm Hg
- D. PAS comprise entre 160-179mm Hg; PAD entre 100-109 mm Hg
- E. PAS comprise entre 165-175 mm Hg; PAD entre 100-109 mm Hg

Source : PROMO 2018**Réponse : D****8. La mesure ambulatoire de la pression artérielle :**

- A. Assure une surveillance automatisée de la PA et un profil de PA sur 24 heures
- B. Est utile en cas ad' HTA blouse blanche
- C. Permet de dévoiler une hypotension orthostatique
- D. Se réalise avec un appareil oscillométrique
- E. Permet de définir une HTA à un seul de PAS=125 mm Hg ; PAD=85 mm Hg

Source : PROMO 2018**Réponse : ABCD****9. Quels sont les seuils de La définition de l'hypertension artérielle au cabinet médical ?**

- A. 135 et/ou 85 mm hg
- B. 130 et/ou 80 mm hg
- C. 140 et/ou 90 mm hg
- D. 120 et ou 70 mm hg
- E. 130 et/ou 85 mm hg

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : C****5. ECG (7 QCM)****1. Sur un ECG normal, un rythme est dit sinusal si:**

- A. Tous les complexes QRS sont précédés d'une onde P identique
- B. Tous les complexes QRS sont suivis d'une onde T asymétrique
- C. La durée de PR est inférieure à 0.20 secondes
- D. L'axe du cœur est entre 0 et 90°
- E. La durée entre RR reste constante

Source : PROMO 2022**Réponse : A****2. L'axe du cœur est normal (entre 0 et 90°) si :**

- A. Le complexe QRS est négatif en DI et AVF
- B. Le complexe QRS est positif en DI et négatif en AVF
- C. Le complexe QRS est négatif en DI et positif en AVF
- D. Le complexe QRS est positif en DI et AVF
- E. Le complexe QRS est positif en V1 et négatif en V6

Source : PROMO 2022**Réponse : D****3. L'onde T :**

- A. Traduit la repolarisation auriculaire
- B. Est précédé du segment ST
- C. Est de morphologie asymétrique
- D. Est négative en AVR
- E. Est toujours suivie d'une onde.

Source : PROMO 2021**Réponse : BCD****4. L'espace PR sur un ECG normal :**

- A. Doit être mesuré du début de l'onde P à la fin de QRS.
- B. Il est de durée inférieure à 0,12 seconde.
- C. Diminue quand la fréquence cardiaque diminue.
- D. Sa durée varie d'une dérivation à une autre.
- E. Sa durée ne doit pas dépasser 0,20 seconde

Source : PROMO 2020**Réponse : E**

5. Sur un ECG normal :

- A. Chaque complexe QRS est précédé d'une onde T,
- B. L'onde P correspond à la dépolarisation des ventricules.
- C. Le segment ST doit être isoélectrique.
- D. La fréquence cardiaque est comprise entre 60 et 100,
- E. La durée de l'onde P est comprise entre 0,12 s et 0,20 s

Source : PROMO 2019**Réponse : CD****6. Les dérivations standards sur un électrocardiogramme :**

- A. Explore la partie frontale du cœur
- B. Sont au nombre de 5 dérivations
- C. Renseignent sur l'axe du cœur
- D. AVR se place sur la main droite
- E. le DII ne fait pas partie de ces dérivations

Source : PROMO 2018**Réponse : ACD****7. Un électrocardiogramme ECG doit comporter au minimum :**

- A. 4 dérivations frontales : DI DII DIII, AVR
- B. 5 dérivations frontales : DI DII DIII, AVR et AVL.
- C. 6 dérivations frontales : DI DII DIII, AVR, AVL et AVF.
- D. 5 dérivations périphériques : V1 à V5.
- E. 6 dérivations périphériques : V1 à V6 .

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : CE****6. EXAMEN CARDIAQUE (10 QCM)****1. le choc de pointe :**

- A. Se palpe habituellement au 4eme ou 5eme espace intercostal sur la ligne médio-claviculaire
- B. Est mobile avec les changements de position
- C. Diminue d'intensité au cours de la fièvre
- D. S'étale au cours de l'insuffisance cardiaque globale
- E. Est recherché avec la pulpe de l'index et du médus

Source : PROMO 2022**Réponse : ABDE****2. Le signe de HARZER positif est le témoin d' :**

- A. Une hypertrophie du ventricule gauche
- B. Une hypertrophie du ventricule droit
- C. Un rétrécissement mitral
- D. Une insuffisance mitrale
- E. Une péricardite.

Source : PROMO 2021**Réponse : B****3. Quelles sont les propositions exactes concernant Le Signe de Harzer ?**

- A. Correspond à la perception des battements cardiaques au niveau de la région sous xiphoïdienne.
- B. Témoin d'une Hypertrophie du Ventricule gauche.
- C. Témoin d'une Hypertrophie du Ventricule droit.
- D. Se recherche chez un patient en position assise.
- E. Un signe constant observé dans l'insuffisance Cardiaque Droite.

Source : P 2020 / P 2018**Réponse : AC****4. Quelles sont les propositions exactes concernant les foyers de l'auscultation cardiaque?**

- A. Correspondent à la situation anatomique des valves correspondantes
- B. Le Foyer Aortique : 2ème espace intercostal gauche
- C. Le Foyer Pulmonaire : 2ème espace intercostal droit
- D. Le Foyer Tricuspidé : 4ème espace intercostal gauche a sa partie interne
- E. Le Foyer Mitral : 5ème EIC gauche en sous mamelonnaire

Source : PROMO 2019**Réponse : DE****5. Le choc de pointe est diminué en cas :**

- A. D'obésité
- B. D'emphysème
- C. D'hyperthyroïdie
- D. D'épanchement péricardique
- E. De fièvre

Source : P 2019 / P 2018**Réponse : ABD****6. Parmi ces propositions, quels sont les Facteurs de Risque Cardio- vasculaires ?**

- A. L'âge supérieur à 50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme.
- B. Le sexe féminin.
- C. L'Hypertension Artérielle.
- D. Le Diabète.
- E. L 'hérédité cardiovasculaire : infarctus du myocarde ou mort subite après l'âge de 55 ans chez le père ou un parent du premier degré de sexe masculin.

Source : PROMO 2018**Réponse : ACD**

7. Les palpitations ; le diagnostic de gravité est posé devant ou lorsque :

- A. Des antécédents familiaux de mort subite
- B. La survenue à l'effort chez un sujet jeune sans antécédent
- C. La présence de trouble du rythme ou de conduction
- D. Le patient ressent une douleur thoracique
- E. L'existence de pic hypertensif concomitant

Source : PROMO 2018**Réponse : ACD****8. Au cours de l'accès de palpitations, l'ECG peut montrer :**

- A. Une arythmie complète par fibrillation
- B. Des extrasystoles supra-ventriculaires
- C. L'ECG est toujours anormal
- D. Un syndrome de wolf-parkinson-white
- E. S'il est normal on arrête les investigations

Source : PROMO 2018**Réponse : ABDE****9. Devant des palpitations on doit rechercher :**

- A. Des signes d'Hypothyroïdie
- B. Un Flutter auriculaire
- C. Un syndrome d'apnée de sommeil
- D. Un sevrage progressif de B-bloqueurs
- E. Une grossesse

Source : PROMO 2018**Réponse : ABCE****10. L'auscultation du foyer mitral se fait au niveau de :**

- A. 4ème espace intercostal gauche à sa partie interne.
- B. 2ème espace intercostal gauche.
- C. 2ème espace intercostal droit.
- D. 5ème espace intercostal gauche en sous-mamelonnaire.
- E. 3ème espace intercostal gauche

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : D****7. LES SOUFFLES CARDIAQUES (7 QCM)****1. Le souffle d'insuffisance mitrale est :**

- A. Holosystolique
- B. Télé diastolique
- C. Systolo-diastolique
- D. Mieux perçu en décubitus latéral gauche
- E. En jet de vapeur

Source : PROMO 2022**Réponse : ADE****2. Pour une description sémiologique d'un souffle cardiaque, il faut préciser :**

- A. Sa chronologie
- B. Son siège d'intensité maximale
- C. Son intensité qui est cotée de 1 à 3
- D. Son irradiation à partir de son foyer maximal
- E. Son timbre

Source : PROMO 2022**Réponse : ABDE****3. L'augmentation inspiratoire du souffle systolique xiphoïdien est un argument en faveur de**

- A. Insuffisance mitrale
- B. Maladie mitrale
- C. Rétrécissement mitral
- D. Insuffisance tricuspидienne
- E. Rétrécissement aortique.

Source : PROMO 2021**Réponse : D****4. A propos des souffles systoliques fonctionnels**

- A. Sont des souffles de régurgitation.
- B. Sont proto ou méso-systoliques.
- C. De très forte intensité.
- D. De timbre rude.
- E. N'irradient pas.

Source : PROMO 2020**Réponse : ABE****5. Quelles sont les caractéristiques sémiologiques rencontrées au cours du Souffle d'une Insuffisances cardiaque :**

- A. Débute juste après le B2
- B. Holosystolique
- C. Siège maximal au 4ème espace intercostal droit
- D. Intensité variable
- E. Irradie vers les vaisseaux du cou

Source : PROMO 2019**Réponse : BD****6. A propos des souffles cardiaques**

- A. Un souffle systolique est toujours organique.
- B. Un souffle d'éjection est un souffle de retour de sang du ventricule vers l'oreillette
- C. Le rétrécissement mitral se traduit par un souffle diastolique au foyer mitral
- D. Un souffle fonctionnel traduit une pathologie des valves cardiaques)
- E. Un souffle holosystolique du foyer aortique correspond à une insuffisance aortique.

Source : PROMO 2018**Réponse : C**

7. L'abolition du B2 associé à un souffle systolique au 2eme espace intercostal droit est retrouvé dans

- A. Le rétrécissement mitral
- B. L'insuffisance mitrale
- C. L'insuffisance Aortique
- D. Le rétrécissement aortique
- E. L'insuffisance tricuspideenne.

Source : RATRAPAGE 2022

Réponse : D

8. L'INSUFFISANCE CARDIAQUE (5 QCM)

1. Parmi les signes suivants, lesquels se voient au cours de l'insuffisance cardiaque droite :

- A. Œdèmes des membres inferieurs
- B. Ascite
- C. Turgescence des jugulaires
- D. Hépatalgie d'effort
- E. Hépatomégalie a bord inferieur tranchant

Source : PROMO 2022

Réponse : ABCD

2. Les oedèmes signes d'insuffisance cardiaque sont souvent :

- A. Blancs
- B. Inflammatoires
- C. Indolores
- D. Prennent le godet
- E. Déclives

Source : PROMO 2021

Réponse : ACDE

3. Quels sont les signes cliniques d'une insuffisance cardiaque droite ?

- A. Les œdèmes des membres inférieurs
- B. Le Reflux hépato-jugulaire
- C. La dyspnée
- D. L'hépatomégalie
- E. Les râles crépitants pulmonaire.

Source : P 2021 / P 2020

Réponse : ABD

4. Une insuffisance cardiaque gauche peut se manifester par :

- A. Une dyspnée d'effort.
- B. Une turgescence des veines jugulaires.
- C. Des œdèmes des membres inférieurs.
- D. Un reflux hépato-jugulaire.
- E. Un œdème aigu du poumon.

Source : PROMO 2020

Réponse : ACE

5. Une insuffisance cardiaque droite se manifeste par :

- A. Une dyspnée d'effort
- B. Une turgescence des veines jugulaires.
- C. Un œdème des membres inférieurs.
- D. Un reflux hépato-jugulaire.
- E. Une bradycardie.

Source : P 2019 / P 2018

Réponse : BCD

9. SYNCOPES ET LIPOTHYMIES(3 QCM)

1. A propos des syncopes :

- A. C'est un trouble de conscience sans perte du tonus postural
- B. Est de début progressif et spontanément régressif, en général long
- C. La syncope d'Adams stocks est une syncope à l'emporte pièce
- D. Le patient se souvient avoir perdu connaissance
- E. Après le retour à la conscience, l'état neurologique est normal.

Source : P 21 / P 20 / P 19 / P 18

Réponse : CE

2. Un ECG au décours d'une syncope peut montrer :

- A. Une Tachycardie ventriculaire
- B. Une bradycardie profonde
- C. Un bloc auriculo-ventriculaire de 1er degré
- D. Peut être normal
- E. Est toujours pathologique

Source : PROMO 2018

Réponse : ABD

3. A propos des syncopes noradrénergiques :

- A. L'Hypotension artérielle s'accompagne d'une tachycardie réflexe.
- B. Elles sont dites syncopes vaso-vagales
- C. sont liées à une hyporéflexie du sinus carotidien
- D. Le test d'inclinaison permet de poser le diagnostic
- E. Elle peut survenir lors d'un effort de défécation

Source : PROMO 2018

Réponse : BDE

10. SEMIOLOGIE VEINEUSE (4 QCM)**1. La thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs :**

- A. Est secondaire à la formation d'un thrombus au niveau de la grande veine saphène
- B. Les signes cliniques d'une TVP des membres inférieurs sont souvent unilatéraux
- C. La TVP peut se manifester cliniquement par une douleur et un œdème au niveau des membres inférieurs.
- D. Le signe de Homans correspond à une douleur provoquée au niveau du mollet lors de la flexion du genou
- E. La complication la plus redoutable au cours d'une TVP est l'ulcère de jambe.

Source : PROMO 2022**Réponse : BC****2. Concernant les varices des membres inférieurs**

- A. Sont secondaires à une atteinte des valvules au niveau des veines profondes
- B. La position debout prolongée et la sédentarité peuvent être des facteurs prédisposants
- C. L'ulcère de jambe est l'une des complications des varices
- D. La Manoeuvre de Trendelenburg fait partie de l'examen clinique des varices
- E. La palpation retrouve un poulx pédiéux absents lors de l'examen clinique.

Source : PROMO 2021**Réponse : BCD****3. A propos des varices :**

- A. Veines superficielles sous cutanées devenues dilatées d'un calibre > 3 mm
- B. Dilatations de petites veines intradermiques dont le diamètre n'excède pas 1 mm.
- C. Peuvent entraîner des douleurs au mollet à la position debout prolongée.
- D. Entraînent des douleurs au mollet à la marche.
- E. Entraînent une disparition du ballotement du mollet.

Source : P 2020 / P 2018**Réponse : AC****4. Une thrombose veineuse profonde d'un membre inférieur est suspectée devant :**

- A. Un œdème unilatéral d'un membre
- B. Une douleur du membre,
- C. Une persistance du ballotement du mollet,
- D. Une rougeur et chaleur unilatérale d'un membre.
- E. Une froideur et absence de poulx.

Source : PROMO 2019**Réponse : ABD****11. SEMIOLOGIE ARTERIELLE (6 QCM)****1. La claudication intermittente du membre inférieur est :**

- A. Une douleur survenant à l'effort
- B. Une douleur au repos
- C. Une douleur inflammatoire
- D. Une douleur survenant après un périmètre de marche bien précis
- E. Une douleur irradiant vers la face postérieure de la fesse et de la cuisse

Source : PROMO 2022**Réponse : AD****2. L'ischémie critique est définie cliniquement par :**

- A. Une douleur au repos
- B. Une douleur uniquement à l'effort
- C. IPS moins de 0.4
- D. IPS moins de 0.7
- E. La présence de Gangrène ischémique

Source : PROMO 2022**Réponse : ACE****3. L'ischémie aigue des membres inférieurs est :**

- A. Une interruption aigue de la circulation artérielle
- B. Une Interruption progressive de la circulation artérielle
- C. Une urgence médico-chirurgicale
- D. Une ischémie critique
- E. L'échodoppler est indispensable pour faire le diagnostic

Source : PROMO 2022**Réponse : AC****4. L'anévrisme de l'aorte abdominale sous rénale se manifeste par :**

- A. Une masse battante et expansive
- B. Une masse battante uniquement
- C. Un signe de DeBakey positif
- D. Une masse mobile
- E. La douleur peut être le signe d'une rupture anévrysmale.

Source : PROMO 2021**Réponse : ACE****5. À propos de l'examen artériel :**

- A. Un poulx irrégulier est sans signification pathologique.
- B. Un souffle artériel est sans signification pathologique.
- C. Une masse pulsatile sur un trajet artériel fait suspecter une lésion anévrysmale.
- D. Le poulx est régulier avec fréquence supérieur à la fréquence cardiaque.
- E. Deux artères symétriques ont des battements synchrones et égaux.

Source : PROMO 2020**Réponse : CE**

6. L'examen des pouls retrouve à l'état normal :

- A. Deux artères symétriques ont des battements synchrones et égaux.
- B. Le pouls peut être irrégulier à l'état normal.
- C. Les pouls fémoral et radial sont synchrones.
- D. Tous les pouls périphériques doivent être perçus (sauf pédieux peut être absent)
- E. La fréquence du pouls est toujours supérieure à la fréquence cardiaque

Source : P 2019 / P 2018**Réponse : ACD****4. SEMIOLOGIE RESPIRATOIRE :****1. SEMIOLOGIE DE LA DYSPNEE (6 QCM)****1. L'orthopnée est une :**

- A. Dyspnée de repos
- B. Dyspnée qui correspond à un stade III de la classification de NYHA
- C. Dyspnée dont l'origine peut être pulmonaire
- D. Dyspnée dont l'origine peut être cardiaque
- E. Dyspnée qui survient à l'orthostatisme

Source : PROMO 2022**Réponse : ACD****2. Les signes de gravité devant une dyspnée sont :**

- A. SAO2 à 90%
- B. FC 120/min
- C. Agitation
- D. Tirage intercostale
- E. Silence auscultatoire

Source : PROMO 2022**Réponse : BCDE****3. Concernant la classification du NYHA :**

- A. Elle évalue l'intensité de la dyspnée
- B. Elle comporte 4 stades
- C. Elle évalue la dyspnée d'origine cardiaque uniquement
- D. Le stade II est une dyspnée pour des efforts important habituels
- E. Le stade I est l'absence de dyspnée-pour des efforts habituels.

Source : PROMO 2021**Réponse : ABDE****4. Quelles sont les propositions exactes concernant la classification du NYHA :**

- A. Elle évalue l'intensité de la dyspnée.
- B. Elle comporte 5 stades.
- C. Elle évalue la dyspnée d'origine cardiaque uniquement.
- D. Le stade II est une dyspnée pour des efforts important habituels
- E. Le stade IV est l'absence de dyspnée pour des efforts habituels.

Source : PROMO 2020**Réponse : AD****5. Une dyspnée stade IV selon la classification de New York Heart Association (NYHA) est une dyspnée**

- A. Pour des efforts importants inhabituels.
- B. Pour des efforts importants habituels.
- C. Pour des efforts peu intenses de la vie courante.
- D. Permanente de repos ou pour des efforts minimes.
- E. Seulement au décubitus.

Source : PROMO 2019**Réponse : D****6. Il y a détresse respiratoire en présence des signes suivants :**

- A. Tirage des muscles intercostaux
- B. Tirage des muscles sterno-cléido-mastoïdiens
- C. Bradypnée à moins de 10 cycles/min
- D. Polypnée de plus de 22cyc /min
- E. Troubles de la conscience

Source : PROMO 2018**Réponse : ABDE****2. DOULEURS THORACIQUES EN PNEUMO (3 QCM)****1. Devant une douleur thoracique, il faut éliminer en urgence :**

- A. Un pneumothorax compressif.
- B. Une embolie pulmonaire
- C. Une tuberculose pulmonaire.
- D. Un cancer bronchique.
- E. Une tamponnade cardiaque

Source : PROMO 2021**Réponse : ABE****2. Quelles sont les signes fonctionnels respiratoires associés à la douleur thoracique ?**

- A. Dyspnée
- B. Toux
- C. Hémoptysie
- D. Sibilants
- E. Frottement pleural.

Source : PROMO 2021**Réponse : ABC**

3. Quelles sont parmi les propositions suivantes, les étiologies pouvant être responsables de douleurs d'origine pulmonaire ?

- A. Un pneumothorax
- B. Un zona intercostal
- C. Un syndrome coronarien aigu
- D. Une pneumonie
- E. Une pleurésie

Source : PROMO 2019

Réponse : ADE

3. SEMIOLOGIE DE LA TOUX (4 QCM)

1. Quels sont les éléments essentiels à rechercher lors de l'interrogatoire d'un patient présentant une toux ?

- A. Date d'apparition de la toux
- B. Couleur des expectorations
- C. Groupe sanguin du patient
- D. Circonstances déclenchantes de la toux
- E. Tonalité et rythme de la toux

Source : PROMO 2022

Réponse : ABDE

2. Quels sont des signes de gravité devant alerter chez un patient toussant ?

- A. Dysphonie et fausses routes
- B. Modification de la toux chez un fumeur
- C. Présence de dyspnée sévère
- D. Absence de fièvre chez un patient jeune
- E. Hémoptysie (crachats sanglants)

Source : PROMO 2022

Réponse : ABCE

3. La toux est :

- A. Un mécanisme non spécifique de défense des voies aériennes
- B. Un raclement de gorge (Hemmage)
- C. Chronique quand sa durée dépasse les 2 semaines
- D. Une expulsion brusque et sonore de l'air contenu dans les poumons
- E. Une maladie grave, chronique et invalidante

Source : PROMO 2021

Réponse : AD

4. Les caractéristiques sémiologiques de la toux:

- A. Mode de début et l'ancienneté (aigue, subaiguë ou chronique).
- B. Le caractère productif ou sec.
- C. L'association avec les autres signes fonctionnels respiratoires
- D. Le caractère permanent ou paroxystique
- E. Le rôle des facteurs de l'environnement.

Source : PROMO 2019

Réponse : ABD

4. EXPECTORATION/VOMIQUE (8 QCM)

1. Une vomique de couleur marron chocolat est pathognomonique :

- A. D'un œdème aigu du poumon
- B. D'une tuberculose pulmonaire
- C. D'une pleurésie purulente
- D. D'un abcès amibien
- E. D'un kyste hydatique du poumon

Source : PROMO 2021

Réponse : D

2. Une toux avec expectoration mousseuse d'apparition aigue devra nous orienter en 1er lieu vers :

- A. Une dilatation des bronches.
- B. Une bronchite chronique.
- C. Une pneumonie.
- D. Un épanchement pleural.
- E. Une Insuffisance cardiaque.

Source : PROMO 2020

Réponse : E

3. Les étiologies qui concernent l'expectoration chronique avec radiographie pulmonaire normale :

- A. Tuberculose pulmonaire.
- B. Bronchite chronique.
- C. Cancer du poumon,
- D. Asthme à dyspnée continue.
- E. Kyste pulmonaire infecté.

Source : PROMO 2020

Réponse : BD

4. Quelle(s) est/sont parmi les caractéristiques suivantes celle(s) rencontrée(s) au cours de la vomique ?

- A. Un début brutal et massif.
- B. Un mode fractionné constant.
- C. Une origine pulmonaire exclusive,
- D. Une quantité évacuée de petite abondance.
- E. Toujours bien tolérée.

Source : PROMO 2020

Réponse : A

5. Quelles sont parmi les propositions suivantes, celles qui concernent l'expectoration ?

- A. Expulsions de sécrétions anormales provenant de la sphère ORL
- B. Peuvent prendre un aspect muqueux ou muco-purulent.
- C. Intérêt de préciser le caractère aigu ou chronique.
- D. l'expectoration est toujours en rapport avec une pathologie infectieuse
- E. L'expectoration ost abondante, mousseuse, blanchâtre ou rosée au cours de l'asthme Bronchique

Source : PROMO 2019

Réponse : BC

6. Quels sont parmi les caractéristiques suivantes celles rencontrées au cours de la vomique ?

- A. Un début progressif sur plusieurs mois.
- B. Une origine toujours pulmonaire
- C. Une quantité évacuée de grande abondance.
- D. Toujours bien tolérée.
- E. Variété d'expectoration caractérisée par son début brutal,

Source : PROMO 2019**Réponse : CE****7. La vomique correspond à une expectoration :**

- A. D'installation brutale
- B. Purulente
- C. Eau de roche
- D. sanguinolente
- E. Perlée

Source : PROMO 2018**Réponse : ABC****8. La vomique est provoquée par la rupture de :**

- A. Un anévrysme
- B. Un kyste hydatique
- C. un abcès pulmonaire
- D. une bulle d'emphysème
- E. une pleurésie

Source : PROMO 2018**Réponse : BCDE****5. HEMOPTYSIE (5 QCM)****1. La différence entre hémoptysie [symptôme] et hémoptysie [maladie] est:**

- A. L'abondance du saignement inférieur ou supérieur a 50 ml/24h
- B. L'abondance du saignement inférieur ou supérieur a 500 ml/24h
- C. La couleur du sang
- D. Les antécédents du patient
- E. Le caractère récidivant de l'hémoptysie.

Source : PROMO 2021**Réponse : A****2. A propos des hémoptysies :**

- A. C'est un saignement extériorisé ou non provenant des voies respiratoires dans un effort de toux
- B. La gravité de l'hémoptysie vient seulement du risque de spoliation (perte) sanguine.
- C. l'hémoptysie est considérée comme étant grave si le volume est > 150ml,
- D. Est le plus souvent due au développement d'une hypervascularisation artérielle systémique au dépend de la circulation bronchique.
- E. Une hémoptysie de minime abondance ne justifie aucune investigation ni surveillance.

Source : P 2020 / P 2019**Réponse : AD****3. Hémoptysie est grave si :**

- A. elle survient sur un terrain respiratoire
- B. Son abondance est > à 200 ml en une fois
- C. Des signes d'état de choc sont présents
- D. Son abondance est inférieure à 300 ml /24h 6
- E. Du sang est également présent lors de vomissements associés

Source : PROMO 2018**Réponse : ABC****4. Cochez les 2 étiologies les plus fréquentes de l'hémoptysie :**

- A. Tuberculose pulmonaire
- B. Malformation vasculaire
- C. Néoplasie pulmonaire
- D. Fibrose pulmonaire
- E. Pneumocystose pulmonaire

Source : PROMO 2018**Réponse : AC****5. Quels sont les diagnostics différentiels à évoquer devant une hémoptysie ?**

- A. Une gingivorragie.
- B. Une hématomèse.
- C. Une expectoration.
- D. Une vomique.
- E. Une épistaxis déglutie

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : ABE****6. DYSPHONIE (3 QCM)****1. Un patient de 50 ans, fumeur, présente une lésion bourgeonnante de la corde vocale droite. L'examen clinique peut retrouver :**

- A. Une dysphonie
- B. Une dyspnée expiratoire
- C. Des épigastralgies
- D. Une adénopathie satellite cervicale
- E. Une perte de poids

Source : PROMO 2022**Réponse : ADE****2. La dysphonie chronique :**

- A. Doit faire suspecter une pathologie tumorale chez tout sujet ethylo-tabagique
- B. Est un trouble de la voix causée par une atteinte organique ou fonctionnelle du larynx
- C. Est le premier symptôme d'une localisation glottique d'un cancer du larynx
- D. S'accompagne toujours d'une dysphagie
- E. Ne nécessite un examen laryngoscopique que chez les patients dont l'âge est supérieur à 60 ans.

Source : PROMO 2021**Réponse : ABC**

3. Quelles sont parmi les propositions exactes, celles concernant la dysphonie ?

- A. Anomalie du son ou du timbre de la voix
- B. Peut-être en rapport avec une obstruction nasale.
- C. Possède la même signification d'une dysarthrie.
- D. Nécessite seulement un examen ORL
- E. Une évolution insidieuse et d'aggravation progressive évoque un cancer du larynx.

Source : PROMO 2019

Réponse : AE

7. SIGNES PHYSIQUES EN PNEUMOLOGIE (5 QCM)

1. L'examen clinique de l'appareil respiratoire peut retrouver le ou les signes fonctionnels suivants :

- A. Une toux sèche
- B. Un thorax en entonnoir
- C. Une diminution des vibrations vocales
- D. Des douleurs thoraciques à type de brûlures
- E. Une gêne respiratoire

Source : PROMO 2022

Réponse : ADE

2. Une matité avec une abolition des murmures vésiculaires évoque :

- A. Un pneumothorax.
- B. Une condensation pulmonaire d'une pneumonie.
- C. Un emphysème pulmonaire
- D. Une pleurésie.
- E. Une bronchite chronique.

Source : PROMO 2020

Réponse : BD

3. Cocher la ou les caractéristiques des râles crépitants parmi les propositions suivantes :

- A. Apparition à la fin de l'inspiration.
- B. Apparition au début de l'inspiration.
- C. Affectés par la toux.
- D. Transmis vers la bouche.
- E. En rapport avec une pathologie laryngée.

Source : PROMO 2020

Réponse : A

4. Cocher les caractéristiques des râles sous crépitants parmi les propositions suivantes :

- A. Apparition au milieu de l'inspiration et l'expiration.
- B. Apparition au début de l'inspiration.
- C. Affectés par la toux.
- D. Transmis vers la bouche.
- E. Equivalents des râles crépitants

Source : P 2019 / P 2018

Réponse : ACD

5. Quelles sont les propositions exactes concernant la percussion pulmonaire ?

- A. On frappe perpendiculairement sur l'articulation inter phalangienne proximale.
- B. Se fait sur les côtes.
- C. Se fait dans l'espace intercostal.
- D. Un tympanisme désigne un épanchement liquidien.
- E. Une matité signifie toujours un épanchement pleural.

Source : RATRAPAGE 2022

Réponse : C

8. SYNDROMES MEDIASTINAUX (4 QCM)

1. Parmi les pathologies suivantes, laquelle ne donne pas un syndrome médiastinal ?

- A. Goitre endothoracique.
- B. Anévrisme de l'aorte ascendante.
- C. Cancer de l'œsophage.
- D. Syndrome cave inférieur.
- E. Laryngite aiguë.

Source : PROMO 2022

Réponse : E

2. Le syndrome cave supérieur est caractérisé par

- A. Une cyanose localisée aux mains et au visage
- B. Un œdème des membres inférieurs
- C. Une turgescence des veines jugulaires
- D. Une circulation veineuse collatérale thoracique
- E. Un reflux hépato-jugulaire.

Source : PROMO 2021

Réponse : ACD

3. Le syndrome cave supérieure comprend :

- A. Un visage pale avec paralysie des cordes vocales
- B. Une cyanose du visage avec œdème et une turgescence des veines du cou.
- C. Dysphonie avec paralysie du récurrent gauche.
- D. Des œdèmes des membres inférieurs.
- E. Une abolition d'un pouls radial.

Source : PROMO 2020

Réponse : B

4. Dans le syndrome cave supérieur, quels sont les éléments parmi les suivants qui sont vrais ?

- A. Erythrose palmaire.
- B. Œdème en pélerine.
- C. Turgescence des veines jugulaires.
- D. Insomnie.
- E. Cyanose des mains

Source : PROMO 2019

Réponse : BCE

9. LES SYNDROMES PULMONAIRES (3 QCM)

1. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles rencontrées dans le syndrome de comblement alvéolaire ?

- A. Les Limites sont floues
- B. Les parois sont fines
- C. Peuvent être systématisées
- D. Évolution très lente et tardive
- E. Renferment souvent un bronchogramme aérique

Source : PROMO 2021

Réponse : ACE

2. Lors d'une condensation pulmonaire systématisée rétractée :

- A. C'est une atélectasie avec augmentation du volume pulmonaire du territoire atteint.
- B. Il y a une diminution ou abolition des vibrations vocales.
- C. Il y a augmentation du murmure vésiculaire.
- D. Il y a abolition des vibrations vocales.
- E. Il y a une matité avec vibrations vocales augmentées.

Source : PROMO 2020

Réponse : E

3. L'examen physique retrouve au cours de la pneumonie :

- A. Un tympanisme.
- B. Une pectoriloquie aphone.
- C. Une matité.
- D. Une augmentation des vibrations vocales.
- E. Une hyperphonie

Source : PROMO 2019

Réponse : BCD

10. SYNDROMES BRONCHIQUES (1 QCM)

1. Quels sont les signes fonctionnels d'une crise d'asthme ?

- A. Bradypnée
- B. Oppression thoracique
- C. Respiration sifflante
- D. Toux
- E. Dyspnée expiratoire.

Source : PROMO 2021

Réponse : BCDE

11. SYNDROMES PLEUREUX (4 QCM)

1. l'examen clinique au cours d'un épanchement pleural liquidien peut retrouver :

- A. Une douleur thoracique latéralisée aggravée par la toux
- B. Une abolition du murmure vésiculaire
- C. Une matité à la percussion
- D. Un tympanisme à la percussion
- E. Une abolition des vibrations vocales

Source : PROMO 2022

Réponse : ABCE

2. Concernant le syndrome d'épanchement pleural liquidien :

- A. La toux est déclenchée avec les changements de positions
- B. La dyspnée est proportionnelle à l'abondance de l'épanchement
- C. La percussion retrouve un tympanisme de l'hémithorax atteint
- D. La ligne de DAMOISEAU radiologique est concave en haut et en dedans
- E. L'exsudat définit un taux de protides < 30g/l dans le liquide pleural.

Source : PROMO 2021

Réponse : ABD

3. L'examen clinique d'un épanchement pleural aérien retrouve :

- A. Une abolition des vibrations vocales
- B. Une matité
- C. Un tympanisme.
- D. Des râles sous crépitants.
- E- Une augmentation du murmure vésiculaire.

Source : PROMO 2020

Réponse : AC

4. Lors d'un épanchement pleural liquidien de grande abondance on retrouve :

- A- Une dyspnée.
- B. Une augmentation des vibrations vocales.
- C. Une abolition des bruits respiratoires normaux.
- D. Une matité au siège de l'épanchement.
- E. Une pectoriloquie.

Source : PROMO 2019

Réponse : ACD

12. PONCTION PLEURALE (3 QCM)

1. Dans la ponction pleurale :

- A. La présence de polynucléaires neutrophiles altérés traduit une pleurésie purulente
- B. Dans l'épanchement transsudatif, il faut compléter par une biopsie pleurale pour le diagnostic étiologique
- C. Le Mycobacterium Tuberculosis peut être mis en évidence par la mise en culture du liquide pleural dans le milieu de Lowenstein-Jensen
- D. L'embolie pulmonaire peut s'accompagner d'un transsudat ou exsudat
- E. Dans les pleurésies de grande abondance, il est toujours indiqué de ponctionner 2000CC en une seule fois.

Source : PROMO 2021**Réponse : ACD****2. Quelles sont les propositions exactes concernant la ponction pleurale ?**

- A. Intérêt thérapeutique uniquement.
- B. Intérêt dans le diagnostic étiologique.
- C. Permet de différencier entre un transsudat et un exsudat.
- D. Se fait sur la ligne axillaire antérieure.
- E. De préférence en position couchée.

Source : PROMO 2020**Réponse : BC****3. Quelles sont les propositions exactes concernant la ponction pleurale ?**

- A. Est un geste paramédical.
- B. Se fait au niveau du bord supérieur de la cote.
- C. Evacuatrice se fait avec un débit rapide.
- D. Peut se compliquer d'un pneumothorax.
- E. N'a qu'un intérêt diagnostique.

Source : PROMO 2019**Réponse : BD**

13. ETUDE CYTOBACTERIOLOGIQUE DES SECRETIONS TRACHEOBRONCHIQUES (3 QCM)

1. Concernant le Diagnostic CytoBactériologique (ECB) des expectorations :

- A. Le diagnostic bactériologique inclut une méthode de culture quantitative quelque soit la bactérie en cause
- B. La présence de plus de 25 cellules épithéliales /champ microscopique est en faveur d'une forte contamination du prélèvement par les bactéries de la flore
- C. En plus des prélèvements respiratoires, le diagnostic bactériologique doit inclure des hémocultures
- D. Le seuil de culture significative pour les expectorations est de 10 bactéries/ml de prélèvement, quelque soit la bactérie en cause
- E. La mise en culture peut être différée quand les bactéries recherchées sont celles appartenant à la flore commensale.

Source : PROMO 2021**Réponse : BC****2. Quelles sont les propositions exactes concernant Les prélèvements des crachats ?**

- A. Au réveil et à jeun.
- B. A n'importe quel moment de la journée.
- C. La contamination salivaire est sans intérêt.
- D. Sur 02 jours de suite uniquement.
- E. Permettent la recherche des BK (tuberculose)

Source : PROMO 2020**Réponse : AE****3. Le prélèvement des crachats par tubage gastrique se fait :**

- A. Au réveil.
- B. Le soir.
- C. A jeun.
- D. En position demi assis.
- E. En décubitus ventral.

Source : PROMO 2019**Réponse : ACD**

PHYSIOPATH

1. THERMOREGULATION (3 QCM)

1. Les frissons thermiques

- A. Sont un mécanisme efficace de thermolyse
- B. Induisent une genèse de chaleur
- C. Reposent sur la contraction des muscles horripilateurs des poils
- D. Reposent sur la formation de chaleur lors des mouvements volontaires
- E. Sont inexistantes chez le nouveau-né

Source : P 2022 / P 2021

Réponse : BE

2. A propos des principes de la thermorégulation :

- A. La convection est un mécanisme de thermolyse
- B. La radiation est un mécanisme de thermogénèse
- C. L'évaporation est un mécanisme de thermolyse
- D. Les frissons sont un mécanisme de thermolyse
- E. Dans la thermogénèse, il y a une vasoconstriction

Source : P 2022 / P 2021

Réponse : ACE

3. Concernant la thermogénèse et la thermolyse

- A. La convection est un mécanisme de thermolyse
- B. La radiation est un mécanisme de thermogénèse
- C. L'évaporation est un mécanisme de thermolyse
- D. L'activité musculaire est un mécanisme de thermolyse
- E. Dans la thermogénèse, il y a une vasoconstriction

Source : PROMO 2020

Réponse : ACE

2. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DENUTRITION (1 QCM)

1. Dans la dénutrition par agression nous observons :

- A. Protéolyse importante pour produire des acides aminés glucoformateurs
- B. inhibition de la protéolyse au profit de la lipolyse
- C. la céto-genèse est fortement stimulée
- D. Une insulino-résistance
- E. Inhibition de la céto-genèse

Source : PROMO 2022

Réponse : ADE

3. TROUBLES HYDROSODES (8 QCM)

1. L'état d'hydratation intracellulaire est reflété par

- A. La kaliémie
- B. La clairance rénale de l'eau libre
- C. L'osmolarité extracellulaire
- D. La tension artérielle
- E. La natriurèse

Source : P 2021 / P 2020

Réponse : C

2. La pression osmotique est la force exercée par:

- A. Un électrolyte en solution, à travers une membrane imperméable
- B. Un électrolyte en solution, à travers une membrane totalement perméable
- C. La pression hydrostatique d'une solution
- D. Un électrolyte en solution, à travers une membrane semi perméable
- E. La circulation sanguine dans les artères

Source : P 2021 / P 2018

Réponse : D

3. Une hypernatrémie :

- A. Entraîne une déshydratation cellulaire obligatoire
- B. Entraîne une hyperhydratation extracellulaire obligatoire
- C. Est responsable d'hyperosmolarité
- D. Entraîne une hyperglycémie
- E. Peut se rencontrer dans le cadre d'un diabète insipide

Source : PROMO 2021

Réponse : ACE

4. Une déshydratation global s'observe quand on a

- A. Une natrémie basse avec un hémocrite élevé
- B. Une natrémie élevée avec hémocrite élevé
- C. Une natrémie élevée avec un hémocrite bas
- D. Une natrémie normale avec un hémocrite bas
- E. Une natrémie basse avec hémocrite bas

Source : PROMO 2021

Réponse : B

5. Une hypotonie plasmatique peut être due à :

- A. Une hyponatrémie
- B. Une hypochlorémie
- C. Une Hypoalbuminémie
- D. Une hyperglycémie (glycémie > 10 g/l)
- E. Une hypoglycémie

Source : PROMO 2020

Réponse : A

6. L'eau vasculaire représente en moyenne :

- A. 30% du poids corporel
- B. 15% du poids corporel
- C. 20 % du poids corporel
- D. 5 % du poids corporel
- E. 60% du poids corporel

Source : PROMO 2018

Réponse : D

7. L'augmentation de l'osmolarité plasmatique a pour conséquence :

- A. Une hyperhydratation intracellulaire
- B. Une hyperhydratation extracellulaire
- C. Une déshydratation Intracellulaire
- D. Une déshydratation extracellulaire
- E. Une hyperhydratation globale

Source : PROMO 2018

Réponse : C

8. La déshydratation globale s'accompagne des signes cliniques suivants, sauf un, lequel ?

- A. Soif
- B. Perte de poids
- C. Hypothermie
- D. Pli cutané
- E. Oligurie

Source : RATRAPAGE 2022

Réponse : C

4. INSUFFISANCE CARDIAQUE (2 QCM)

1. Au cours de l'insuffisance cardiaque, les mécanismes d'adaptation au niveau cardiaque ont comme objectifs :

- A. L'augmentation de la fréquence cardiaque
- B. La diminution de la fréquence cardiaque
- C. L'augmentation de la contractilité cardiaque
- D. Le maintien du volume d'éjection systolique
- E. La diminution de la contractilité cardiaque

Source : P22 / P 21 / P 20 / P 19 / P 18 Réponse : ACD

2. Les mécanismes d'adaptation au niveau périphérique au cours de l'insuffisance cardiaque, sont :

- A. La vasoconstriction artériolaire.
- B. La vasodilatation artériolaire.
- C. L'augmentation de l'extraction périphérique d'oxygène
- D. La diminution de l'extraction périphérique d'oxygène
- E. La rétention hydrosodée

Source : PROMO 2020

Réponse : ACE

5. ETATS DE CHOC HYPOVOLEMIQUE (5 QCM)

1. Le choc hypovolémique correspond à:

- A. Une diminution du TaO₂ par baisse du volume sanguin total
- B. Une augmentation du volume d'éjection systolique
- C. Une diminution du retour veineux
- D. Une augmentation du tonus vasculaire
- E. Une diminution de l'extraction en O₂

Source : P 2022 / P 2021

Réponse : AC

2. Face à un choc hypovolémique, le système sympathique réagit au début par:

- A. Diminution des résistances vasculaires
- B. Stimulation des barorécepteurs et chémorécepteurs
- C. Diminution de la FC et de la contractilité myocardique
- D. Sécrétion des catécholamines endogènes
- E. Libération d'angiotensine II (système RAA, et non sympathique)

Source : P 2022 / P 2021

Réponse : BD

3. L'état de choc hypovolémique est dit décompensé :

- A. Lorsque Le système sympathique est inhibé par l'acidose métabolique
- B. Quand Le traitement est bien conduit
- C. lorsque l'extraction en oxygène augmente
- D. Quand s'installe une bradycardie
- E. lorsque le métabolisme produit du lactate en anaérobiose

Source : PROMO 2021

Réponse : AD

4. Dans le choc hémorragique la triade létale est constituée de :

- A. Coagulopathie, hémodilution, thrombopénie
- B. Coagulopathie, hypothermie, hypocalcémie
- C. Coagulopathie, hypothermie, acidose
- D. Coagulopathie, anémie, acidose
- E. Coagulopathie, inflammation, thrombopénie

Source : P 2020 / P 2018

Réponse : C

5. Dans l'état de choc, l'ischémie est responsable de :

- A. Métabolisme anaérobie pour assurer une production minimale d'ATP
- B. Baisse de l'extraction de l'O₂
- C. Dysfonction des pompes Na⁺/K⁺ ATPase dépendantes avec accumulation d'eau dans les cellules
- D. Perte des propriétés procoagulantes de l'endothélium
- E. Production accrue de substances toxiques

Source : P 2020 / P 2018**Réponse : ACE**

6. ETATS DE CHOC SEPTIQUE (6 QCM)

1. Le choc septique est caractérisé par :

- A. Une vasodilatation excessive due à la libération de médiateurs inflammatoires
- B. Une activation du système immunitaire entraînant une libération massive de cytokines
- C. Une hypovolémie relative due à une fuite plasmatique dans le compartiment interstitiel
- D. Une augmentation de la contractilité myocardique pour compenser l'hypotension
- E. Une altération de l'extraction tissulaire de l'oxygène

Source : PROMO 2022**Réponse : ABCE****2. Dans le choc septique, la dysfonction endothéliale entraîne :**

- A. Une augmentation de la perméabilité capillaire avec fuite plasmatique
- B. Une diminution de l'adhésion des leucocytes à l'endothélium
- C. Une activation excessive de la coagulation favorisant la microthrombose
- D. Une inhibition complète de la production de NO
- E. Une propagation systémique de l'agent pathogène

Source : PROMO 2022**Réponse : AC****3. Les altérations hémodynamiques du choc septique comprennent :**

- A. Une diminution des résistances vasculaires systémiques
- B. Une augmentation du débit cardiaque dans les premiers stades
- C. Une hypovolémie relative liée à une redistribution des fluides
- D. Une pression veineuse centrale toujours élevée
- E. Une réduction du retour veineux

Source : PROMO 2022**Réponse : ABCE****4. Au cours des états septiques et du choc septique**

- A. Existe une augmentation des besoins tissulaires en oxygène
- B. la vasoplégie est rarement observée
- C. La diminution de la perméabilité capillaire est à l'origine de l'hypovolémie
- D. Existe une augmentation de l'extraction tissulaire en oxygène
- E. le débit cardiaque est conservé

Source : P 2020 / P 2018**Réponse : A****5. Au cours du choc septique, l'activation de la coagulation :**

- A. Peut être responsable de la survenue de l'embolie pulmonaire
- B. Aboutit à la formation de fibrine par le déclenchement la voie extrinsèque
- C. Est le résultat de la combinaison du facteur tissulaire et des plaquettes
- D. Déclenche la Libération dans la circulation systémique de la protéine C
- E. Survient après l'atteinte hépatique

Source : PROMO 2019**Réponse : ABC****6. A cours du choc septique, les facteurs pro inflammatoires :**

- A. Aggravent l'hypotension artérielle
- B. Sont représentés par les Interleukines 6 (IL-6), les IL-10 et les TNF (Tumor Necrosis Factor)
- C. Sont libérés par les lymphocytes T CD4 Th1
- D. Provoquent le SIRS (Syndrome de réponse inflammatoire systémique)
- E. Son responsable de la formation de thrombine

Source : PROMO 2019**Réponse : AD**

7. ETATS DE CHOC CARDIOGENIQUE (2 QCM)

1. l'état de choc cardiogénique peut avoir comme mécanisme étiopathogénique:

- A. Bradycardies ou tachycardies extrêmes
- B. Augmentation de la contractilité myocardique
- C. Dysfonctions du cœur droit
- D. Causes mécanique : insuffisance mitrale aigue
- E. Infection sévère mal contrôlée

Source : PROMO 2019**Réponse : ACD**

2. Les mécanismes d'adaptation cardio-vasculaire au cours du choc cardiogénique sont :

- A. Activation du système nerveux sympathique
- B. Vasodilatation artérielle et veineuse
- C. Augmentation de la contraction myocardique.
- D. Rétention hydro sodée par activation du système rénine-angiotensine-aldostérone
- E. Sécrétion du facteur atrial natriurétique (FAN)

Source : PROMO 2019

Réponse : : ACDE

8. ETATS DE CHOC ANAPHYLACTIQUE (2 QCM)

1. Concernant le choc anaphylactique :

- A. Existe une insuffisance circulatoire aigue
- B. La réaction allergique est toujours de nature immunologique
- C. Il se produit une libération brutale de médiateurs provenant des mastocytes tissulaires et des basophiles sanguines
- D. L'histamine est le seul médiateur libéré
- E. Survient après quelques jours suite à l'exposition a un allergène

Source : P 20 / P 19 / P 18

Réponse : AC

2. L'histamine est le principal médiateur du choc anaphylactique, elle entraîne :

- A. Bronchodilatation
- B. Bronchoconstriction
- C. Libération de monoxyde d'azote (NO)
- D. Vasodilatation périphérique
- E. Vasoconstriction périphérique

Source : PROMO 2020

Réponse : BCD

9. HYPERTENSION ARTERIELLE (4 QCM)

1. Dans l'HTA secondaire d'origine rénovasculaire:

- A. Peut être due à une maladie Atherosclérotique
- B. La sténose de l'artère rénale peut être uni ou bi latéral
- C. L'inactivation de système rénine angiotensine aldostérone
- D. Peut être due à une maladie fibromusculaire de la media
- E. Peut être due à une Glomérulonéphrites chroniques

Source : PROMO 2022

Réponse : ABD

2. Dans l'HTA secondaire d'origine endocrine :

- A. Due à une décharge excessive des catécholamines
- B. Due à un hypoaldostérisme primaire
- C. Hypersécrétion primaire des glucocorticoïdes
- D. Traitement par des anticonceptionnels oraux
- E. Diminution de la synthèse hépatique d'angiotensinogène

Source : PROMO 2022

Réponse : ACD

3. Dans l'HTA primaire, l'insulinorésistance et de l'hyperinsulinisme entraîne une aggravation de la dysfonction endothéliale et de l'athérosclérose par :

- A. Augmentation supplémentaire de l'activation sympathique
- B. Augmentation de la production endothéliale de NO
- C. Potentialisation des effets de remodelage vasculaire de l'Angiotensine II
- D. Effets pro-inflammatoire et pro-thrombotique
- E. Diminution de la prolifération de la musculature lisse vasculaire

Source : P 21 / P 20 / P 19 / P 18

Réponse : ACD

4. Le rôle de l'obésité Abdominale et du syndrome métabolique dans l'HTA primaire est déterminé par

- A. Diminution du substrat du système rénine angiotensine aldostérone.
- B. Libération de l'angiotensinogène par les adipocytes
- C. L'hypersécrétion de la leptine par les adipocytes
- D. Synthèse de précurseur du fibrinogène par les adipocytes
- E. Diminution de la viscosité sanguine

Source : P 20 / P 19 / P 18

Réponse : BCD

10. OAP (3 QCM)

1. Les principes de la loi de Starling intervenants lors d'un œdème aigu du poumon (OAP), ont comme objectifs de :

- A. Protéger le poumon et le maintenir sec.
- B. Protéger le poumon et le maintenir congestif
- C. Maintenir le liquide dans les capillaires pulmonaires
- D. Maintenir le liquide dans l'espace interstitiel alvéolaire
- E. Maintenir le liquide dans les alvéoles pulmonaires.

Source : P 22 / P 21 / P 19 / P 18

Réponse : AC

2. L'œdème aigu du poumon de cause cardiogénique est caractérisé par :

- A. Pression capillaire pulmonaire > 30 mm Hg
- B. Taux de protéines dans le liquide d'œdème > 30 g/l
- C. Une membrane alvéolocapillaire intacte
- D. Absence d'une atteinte cardiaque
- E. Le liquide d'œdème est un exsudat

Source : PROMO 2021

Réponse : AC

3. L'augmentation de la pression hydrostatique dans la microcirculation pulmonaire au cours de l'OAP cardiogénique, sera responsable de :

- A. L'extravasation de liquide dans le tissu interstitiel puis alvéolaire.
- B. L'extravasation de liquide dans le tissu alvéolaire puis interstitiel.
- C. L'hypoxémie.
- D. L'augmentation de la compliance pulmonaire.
- E. La diminution de la compliance pulmonaire.

Source : PROMO 2020

Réponse : ACE

11. TROUBLES DE L'HEMATOSE (2 QCM)

1. L'espace mort :

- A. Est défini comme un espace ventilé mais non perfusé
- B. Est défini comme un espace perfusé mais non ventilé
- C. Est dit anatomique : correspond à la zone de conduction et la partie non alvéolisée de la zone de transition (150 ml)
- D. Est dit espace mort alvéolaire : correspond aux alvéoles ventilés mais non perfusés (10 ml)
- E. Est dit Espace mort physiologique ou total : correspond à la somme des deux espaces mort anatomique et alvéolaire (160 ml)

Source : PROMO 2022

Réponse : ACDE

2. L'Effet shunt est défini par :

- A. Régions alvéolaires hypoventilées bien perfusées
- B. Régions alvéolaires normalement ventilées bien perfusées
- C. Régions alvéolaires hypo perfusées hypo ventilées
- D. Régions alvéolaires hyper ventilées hypo perfusées
- E. Une altération du rapport ventilation/perfusion alvéolaire

Source : PROMO 2021

Réponse : AE

12. INSUFFISANCE RESPIRATOIRE (2 QCM)

1. Dans l'insuffisance respiratoire aigüe, l'effet espace mort se traduit par :

- A. Une ventilation faible ou absente par rapport à la perfusion
- B. Des rapports ventilation/perfusion (VA/Q) inférieurs à 1, parfois proches de 0
- C. Des rapports VA/Q supérieurs à 1, parfois infinis
- D. Une perfusion faible ou absente par rapport à la ventilation
- E. L'absence de ventilation et de perfusion

Source : P22 / P 21 / P 20 / P 19 / P 18 Réponse : CD

2. Dans l'insuffisance respiratoire aigüe, l'effet shunt intra-pulmonaire s'explique par :

- A. Une ventilation faible ou absente par rapport a la perfusion
- B. Des rapports VA/Q supérieurs à 1, parfois infinis
- C. Des rapports ventilation/perfusion (VA/Q) inférieurs à 1, parfois proches de 0
- D. Une perfusion faible ou absente par rapport à la ventilation
- E. L'absence de ventilation et de perfusion

Source : P22 / P 21 / P 19 / P 18

Réponse : AC

13. MALADIE THROMBOEMBOLIQUE (1 QCM)

1. La triade de 《 VIRCHOW 》 de la thrombose veineuse comprend:

- A. Stase veineuse
- B. Thrombocytose
- C. Altération endothéliale
- D. Polyglobulie
- E. Hypercoagulabilité

Source : P 22 / P 21 / P 19 / 18

Réponse : ACE

BIOCHIMIE

1. BIOCHIMIE DE L'HOMME SAIN (5 QCM)

1. Un marqueur biologique devrait :

- A. avoir une sensibilité élevée mais une faible spécificité
- B. être utilisable dans le cadre de l'urgence
- C. permettre de différencier statistiquement une population saine d'une population malade
- D. libéré tardivement
- E. être facile et rapide à dose

Source : PROMO 2022**Réponse : BCE**

2. Cocher les réponses justes concernant le dosage d'un marqueur biologique :

- A. Les sujets sains sont classés en vrai négatifs quand le test est négatif
- B. Les sujets malades sont classés faux positifs quand le test est négatif
- C. Son intervalle de référence inclus 95% des valeurs mesurées
- D. Il est idéal quand il permet de distinguer les vrais négatifs des vrais positifs.
- E. Une valeur de glycémie plasmatique à jeun $> 1,25$ g/L ou d'HbA1c $\geq 6,5$ % constitue un seul pour poser le diagnostic du diabète

Source : PROMO 2022**Réponse : ACDE**

3. Les biomarqueurs sont de nature des :

- A. Marqueurs cellulaires à faible concentration concentrations.
- B. Éléments minéraux.
- C. Composés organiques simples.
- D. Molécules biologiques complexes.
- E. Composés toxiques.

Source : PROMO 2021**Réponse : ABCD**

4. Un marqueur biologique idéal doit :

- A. avoir une sensibilité élevée mais une faible spécificité.
- B. être utilisable que dans le cadre d'urgence.
- C. permettre de différencier statistiquement une population saine d'une population malade.
- D. être libéré tardivement.
- E. être facile et rapide à doser.

Source : PROMO 2020**Réponse : CE**

5. De part et d'autre d'une valeur seuil, les malades se répartissent en :

- A. Vrai positif quand le test est positif chez les sujets malades.
- B. Faux négatif quand le test est négatif chez les sujets sains.
- C. Vrai négatif quand le test est négatif chez les sujets malades.
- D. Faux positif quand le test est positif chez les sujets sains.
- E. Vrai positif quand le test est positif chez les sujets sains.

Source : PROMO 2020**Réponse : AD**

2. LES DIFFERENTES ETAPES DE L'ANALYSE BIOCHIMIQUE (4 QCM)

1. Cocher les réponses justes à propos du prélèvement sanguin :

- A. L'aspiration trop rapide du sang au cours du prélèvement peut entraîner une hémolyse.
- B. La pose du garrot ne doit pas dépasser une minute
- C. L'interprétation de certains paramètres biologiques nécessite la connaissance de l'âge et du sexe.
- D. Lors du prélèvement de plusieurs tubes, l'ordre de remplissage est le suivant : Tube citraté, Tube sec, tube hépariné, tube EDTA et enfin tube avec inhibiteur de glycolyse.
- E. L'homogénéisation des tubes après prélèvement n'est pas nécessaire

Source : PROMO 2022**Réponse : ABC**

2. Quel type de tube (anticoagulant) est nécessaire à la bonne exécution des tests de coagulations ?

- A. EDTA (Violet).
- B. Fluor (Gris)
- C. Sec(jaune).
- D. Héparine (Vert).
- E. Citrate (Bleu).

Source : P 2021 / P 2019**Réponse : E**

3. Parmi les propositions suivantes, indiquez les facteurs qui peuvent Influenceriez résultat biochimique :

- A. Un jeûne d'une durée $\geq$ à 10h.
- B. Un volume de sang insuffisant dans le tube.
- C. Tube hémolysé.
- D. Une hyperlipémie.
- E. Une pose du garrot d'une durée de moins de 30 secondes.

Source : PROMO 2020**Réponse : BCD**

4. A propos du prélèvement sanguin :

- A. L'aspiration trop rapide du sang au cours du prélèvement peut entraîner une hémolyse
- B. La veine médiane est une veine de référence pour effectuer un prélèvement veineux
- C. L'ionogramme sanguin est réalisé à partir d'un prélèvement effectué sur tube à héparine de sodium
- D. Lors du prélèvement de plusieurs tubes, l'ordre de remplissage est le suivant : Tube citrate, Tube sec, tube hépariné, tube EDTA et enfin tube avec inhibiteur de glycolyse
- E. L'homogénéisation des tubes après prélèvement n'est pas nécessaire

Source : PROMO 2018**Réponse : AC**

3. EXPLORATION DU METABOLISME DES LIPIDES ET DES LIPOPROTEINES THERMOGENESES (15 QCM)

1. Parmi les pathologies suivantes laquelle ne donne pas une hyperlipoprotéinémie secondaire:

- A. Le diabète de type 2.
- B. L'hypothyroïdie.
- C. L'hypoparathyroïdie
- D. Le syndrome néphrotique.
- E. La cholestase.

Source : PROMO 2021**Réponse : C****2. Les chylomicrons sont caractérisés par :**

- A. Ils sont composés en majeure partie de triglycérides.
- B. Ils contiennent majoritairement de l'apo B100.
- C. Ils sont très mobiles à l'électrophorèse.
- D. La concentration plasmatique est plus élevée en période postprandiale
- E. Ce sont les plus volumineuses des lipoprotéines plasmatiques.

Source : PROMO 2021**Réponse : ADE****3. Concernant les lipoprotéines, quelles sont les propositions exactes ?**

- A. Les VLDL sont les lipoprotéines les plus riches en protéines.
- B. L'hyperlipoprotéinémie de type III est caractérisée par la présence d'IDL.
- C. L'hyperlipoprotéinémie de type IIb correspond à une hyperlipidémie mixte.
- D. Une concentration basse de HDL-cholestérol est un facteur de risque cardiovasculaire
- E. Le calcul du LDL-cholestérol par la formule de Friedewald est applicable pour une triglycéridémie à 5,0 g/L.

Source : PROMO 2021**Réponse : BCD****4. Parmi les examens suivants, quels sont ceux qui font partie du bilan lipidique de deuxième intention ?**

- A. Le dosage du cholestérol total.
- B. Le dosage des triglycérides.
- C. Le dosage de l'apoprotéine B.
- D. Le dosage de l'apoprotéine A1.
- E. Lipidogramme

Source : PROMO 2020**Réponse : CDE****5. Parmi les propositions suivantes concernant l'hyperlipidémie primitives de type IIa, indiquez laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) :**

- A. L'aspect du sérum est lactescent.
- B. Est une hypertriglycéridémie pure.
- C. Est une hyperlipidémie familiale combinée.
- D. Peut être due à une mutation du gène du récepteur de l'apo B100.
- E. Présente un faible pouvoir athérogène.

Source : P 2022 / P 2020**Réponse : D****6. Le bilan lipidique de base comprend :**

- A. Le dosage du cholestérol total (CT)
- B. le dosage des triglycérides (TG)
- C. Le calcul ou dosage direct du LDLc
- D. Le dosage de l'apoprotéine B.
- E. Le dosage de l'apoprotéine A1.

Source : P 2022 / P 2019**Réponse : ABC****7. L'hyperlipidémie primitives de type IIa :**

- A. Est une hypercholestérolémie par augmentation des IDL
- B. Est une hypercholestérolémie pure par augmentation des LDL.
- C. Est une hyperlipidémie familiale combinée,
- D. Peut être due à une mutation du gène du récepteur de l'Apo B/E
- E. Présente un faible pouvoir athérogène.

Source : PROMO 2019**Réponse : BD****8. Chez un patient atteint d'hyperlipidémie de type III, on observe :**

- A. Une augmentation-importante des chylomicrons par déficit en lipoprotéine lipase.
- B. La présence de lipoprotéine de taille intermédiaire IDL.
- C. Un phénotype E1/E1.
- D. Une augmentation des triglycérides et du cholestérol total
- E. Un aspect limpide du sérum.

Source : PROMO 2018**Réponse : B**

9. Concernant les hyperlipoprotéinémies, quelles sont les propositions exactes ?

- A. L'hyperlipoprotéinémie de type IIb est une hypercholestérolémie pure.
- B. Le calcul du LDL cholestérol par la formule de FRIEDWALg est applicable pour un taux de triglycéride à 4.38/L
- C. Le type IIa, IIb et III sont athérogènes.
- D. Un taux de HDL cholestérol à 0.20g/l est un facteur de risque cardio vasculaire.
- E. Le type VI est fréquemment associé au diabète sucré.

Source : PROMO 2018**Réponse : CDE****10. Concernant l'hypertriglycéridémie familiale type VI de Fredrickson, quelles sont les propositions exactes ?**

- A. Augmentation de la synthèse hépatique des VLDL.
- B. Le cholestérol total > 6/l
- C. Les triglycérides sont augmentés
- D. Aspect du sérum opalescent
- E. S'observe dans l'hyperthyroïdie

Source : PROMO 2018**Réponse : ACD****11. Parmi les facteurs de risque cardiovasculaire, on peut citer :**

- A. Un âge supérieur à 50 ans chez l'homme
- B. Un âge inférieur à 50 ans chez la femme
- C. Une Hypotension artérielle permanente
- D. Un HDLc < 0,40g/l
- E. Diabète de type 1

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : D****12. Concernant l'exploration d'une anomalie lipidique :**

- A. Recommandée chez les sujets jeunes
- B. Recommandée chez tous les adultes âgés de moins de 80 ans avec au moins un FR.
- C. Si le bilan initial est anormal, il faut le répéter pour confirmation 2 à 4 semaines plus tard, sans régime ni médication.
- D. L'estimation du non-cholestérol HDL (non-HDLc) fait partie du bilan de deuxième intention
- E. Le non-HDLc est actuellement considéré plus indicative que la fraction de LDL-cholestérol pour l'évaluation du risque de MCV.

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : BCE****13. Un sérum lactescent :**

- A. Peut témoigner de la présence en excès des VLDL
- B. Peut témoigner de la présence en excès des chylomicrons
- C. Peut témoigner d'une augmentation des LDL
- D. Nécessite de faire un test de crémage
- E. Témoinne d'un bilan lipidique normal

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : BD****14. Une hypoHDLémie (diminution de la fraction HDLc) est suspectée devant :**

- A. Un taux inférieur à 0,6g/l chez l'homme
- B. Un taux inférieur à 1g/l quelque le sexe
- C. Un taux inférieur à 0,4 g/l chez l'homme
- D. Un taux supérieur à 0,5g/l chez la femme
- E. Un taux inférieur à 1,3 g/l chez l'homme

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : C****15. Le LDLc :**

- A. Il doit être inférieur à 1g/l chez les patients sans facteurs de risque
- B. Représente le bon cholestérol
- C. Le risque cardiovasculaire augmente de façon exponentielle avec le taux de LDLc
- D. Il doit être inférieur à 0,70 g/l chez les patients à haut risque cardiovasculaire
- E. Est le principal paramètre d'évaluation du suivi thérapeutique des patients.

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : CDE**

4. EXPLORATIONS BIOCHIMIQUES DU STRESS OXYDATIF (9 QCM)

1. Au sujet des radicaux libres

- A. Ont l'ensemble de leurs électrons appariés.
- B. Leur temps de demi-vie est très long
- C. Ne sont pas nocifs pour l'organisme
- D. Le radical hydroxyle (OH) est le moins toxique
- E. Entraînent des modifications de structure et de fonction de plusieurs molécules biologiques.

Source : PROMO 2022**Réponse : E****2. Parmi les vitamines suivantes, lesquelles ont un effet anti-oxydant :**

- A. Vitamine A.
- B. Vitamine B6.
- C. Vitamine B12.
- D. Vitamine C.
- E. Vitamine E.

Source : PROMO 2022**Réponse : ADE**

3. Quelles sont les principales sources de radicaux libres dans l'organisme ?

- A. Les espèces réactives de l'oxygène (ERO) et de l'azote (ERN).
- B. Les espèces réactives de l'oxygène (ERO) et du carbone (ERC).
- C. Les espèces réactives de l'oxygène (ERO) et de l'hydrogène (ERH).
- D. Les espèces réactives de l'azote (ERN) et de l'hydrogène (ERH)
- E. Les espèces réactives de l'hydrogène (ERH) et de l'azote (ERN).

Source : PROMO 2021**Réponse : A****4. Parmi les systèmes antioxydants de l'organisme, on retrouve :**

- A. Le radical hydroxyle.
- B. Le glutathion.
- C. Le peroxyde d'hydrogène.
- D. Les vitamines A, C et E.
- E. La catalase

Source : PROMO 2021**Réponse : BDE****5. Concernant le stress oxydatif :**

- A. Il est toujours lié à l'apparition des maladies chroniques,
- B. Il peut être le facteur déclenchant de certaines pathologies.
- C. Est le résultat d'un déséquilibre entre les systèmes oxydants et les systèmes antioxydants de l'organisme.
- D. Il est toujours d'origine externe.
- E. C'est un mécanisme diffus dans l'organisme.

Source : PROMO 2020**Réponse : BC****6. Concernant les espèces réactives de l'oxygène ERO :**

- A. Sont des molécules oxygénées fortement réactives et instables.
- B. L'anion superoxyde O_2^- est une ERO fortement produite par le métabolisme.
- C. Les ERO ne sont produites qu'après exposition à la lumière UV.
- D. Elles peuvent entraîner des cassures d'ADN.
- E. Celles produites par radiation ionisante détruisent les lipoprotéines.

Source : PROMO 2020**Réponse : ABD****7. L'exploration du degré de stress oxydant peut se faire par :**

- A. Dosage des isoprostanes.
- B. Dosage de la glycémie et de l'HbA1c.
- C. Dosage du fer, de la transferrine et de l'exploration du métabolisme martial.
- D. Dosage de la CRP.
- E. Dosage de la créatinine.

Source : PROMO 2020**Réponse : ACD****8. Au sujet du stress oxydant :**

- A. il est dû à une surproduction d'enzymes de protection antioxydante.
- B. La mitochondrie joue un rôle important dans le développement du stress oxydant.
- C. Les radicaux libres ont une durée de vie très longue.
- D. Le stress oxydant est associé à plusieurs pathologies comme les cancers et les maladies cardiovasculaires
- E. L'âge n'a aucune influence sur le stress oxydant.

Source : PROMO 2019**Réponse : BD****9. Parmi les molécules suivantes, laquelle est une espèce réactive de l'Oxygène :**

- A. Le glutathion
- B. La catalase
- C. Le radical hydroxyl
- D. La vitamine A
- E. Le Zinc

Source : PROMO 2019**Réponse : C**

5. BIOMARQUEURS CARDIAQUES (10 QCM)

1. Une élévation de la troponine est observée :

- A. Uniquement en cas d'infarctus du myocarde.
- B. En cas d'insuffisance cardiaque sévère aigue ou chronique.
- C. En cas d'embolie pulmonaire.
- D. En cas d'un choc septique.
- E. Uniquement en cas d'insuffisance cardiaque.

Source : PROMO 2022**Réponse : BCD**

2. Concernant les biomarqueurs cardiaques :

- A. Les troponines T hypersensibles (TnT Hs) ou I Ultra-Sensible (TnI Us) ont une excellente valeur prédictive négative pour l'IDM.
- B. Le dosage des biomarqueurs type CPK-MB, copeptine ou h-FABP est toujours recommandé dans la démarche diagnostique du SCA.
- C. En cas de suspicion d'IDM, la cinétique de la troponines TnT Hs à HO-H1 permettrait de classer les patients en deux catégories.
- D. Le dosage de la BNP permettrait de différencier entre une dyspnée d'origine cardiaque ou pulmonaire.
- E. Le NT-Pro BNP possède une très bonne valeur prédictive négative et positive pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque.

Source : P 2021 / P 2018**Réponse : ADE****3. Parmi les examens biologiques suivants, quel est celui prescrit dans le diagnostic biochimique d'un infarctus du myocarde ?**

- A. Alanine aminotransférase.
- B. Myoglobine.
- C. Troponine.
- D. CKmb.
- E. Gamma glutamyltransférase.

Source : PROMO 2021**Réponse : C****4. Concernant l'insuffisance cardiaque :**

- A. Peut-être secondaire l'athérosclérose.
- B. La troponine est la molécule de choix pour l'évaluation de la maladie.
- C. La BNP est sécrétée par le ventricule, et a une action diurétique et vasodilatatrice.
- D. Le pro-BNP est la molécule de choix pour le diagnostic et pronostic de la maladie
- E. Le pro-BNP est sécrété par l'oreillette suite à une diminution du volume diastolique.

Source : PROMO 2020**Réponse : ACD****5. Concernant l'infarctus du myocarde :**

- A. Est défini comme une nécrose ischémique accompagnée de sécrétion de marqueurs mesurables.
- B. Les marqueurs enzymatiques ASAT, ALAT, LDH sont des marqueurs précoces et spécifiques.
- C. La myoglobine est un bon marqueur de suivi du risque de ré-infarctus.
- D. La troponine reste à ce jour le marqueur de choix de diagnostic et de pronostic.
- E. La troponine est produite par le ventricule gauche.

Source : PROMO 2020**Réponse : ACD****6. Concernant les marqueurs cardiaques :**

- A. Le marqueur idéal doit être sensible, spécifique et précoce.
- B. La troponine ultrasensible doit être mesurée à l'admission et 2heures après pour le diagnostic.
- C. La troponine ne peut être utilisée pour le suivi de l'infarctus du myocarde.
- D. La myoglobine est un marqueur précoce mais peu sensible contrairement à la troponine.
- E. L'intérêt d'un marqueur cardiaque est insuffisant si l'ECG est négatif

Source : PROMO 2020**Réponse : ABD****7. Lesquelles sont des marqueurs biochimiques des maladies coronaires :**

- A. Lactate déshydrogénase.
- B. La Créatine Kinase et isoformes.
- C. La Myoglobine.
- D. Les troponines.
- E. Le Peptide Natriurétique de type B (BNP).

Source : PROMO 2019**Réponse : ABCD****8. Concernant les marqueurs biochimiques de l'infarctus du myocarde :**

- A. La myoglobine est un marqueur cardiospécifique.
- B. La CK-MB augmente plus rapidement que la myoglobine.
- C. L'ASAT reste actuellement un marqueur de choix pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde.
- D. La troponine permet un diagnostic de l'infarctus du myocarde.
- E. La troponine est un marqueur cardiospécifique.

Source : PROMO 2019**Réponse : DE****9. Quels sont les indications du dosage des troponines :**

- A. Toutes les atteintes cardiaques avec ischémie et souffrance myocardique.
- B. Diagnostic rétrospectif des IDM.
- C. Dysfonctions ventriculaires diastoliques.
- D. Atteinte myocardique au cours des péricardites et des myocardites .
- E. Dyspnées d'étiologie difficile

Source : PROMO 2019**Réponse : ABD**

10. Concernant les biomarqueurs cardiaques :

- A. Un marqueur biologique idéal doit avoir une spécificité et sensibilité élevées
- B. Les biomarqueurs ne permettent pas un diagnostic précoce
- C. Ne peuvent être utilisés qu'en milieu hospitalier
- D. Les troponines cardiaques ont une très bonne spécificité coronarienne
- E. La troponine C représente un marqueur de choix en cardiologie

Source : PROMO 2018**Réponse : A**

6. EXPLORATIONS BIOCHIMIQUES DES LIQUIDES DE PONCTION (6 QCM)

1. Lequel de ces paramètres permet de différencier un liquide d'ascite issu d'une transsudation de celui issu d'un processus d'exsudation ?

- A. Glucose.
- B. Sodium.
- C. Potassium.
- D. Protéines.
- E. Chlorure.

Source : PROMO 2022**Réponse : D****2. Parmi les propositions suivantes concernant l'exploration biochimique d'une pleurésie, Indiquez laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)**

- A. Un taux des protides inférieur à 20 g/L est en faveur d'un processus exsudatif.
- B. Un taux des protides supérieur à 50 /L fait suspecter fortement le diagnostic de la tuberculose
- C. Un quotient LDH pleurales/LDH plasmatiques supérieur à 0,6 est en faveur d'un processus exsudatif.
- D. Un taux de glucose dans l'épanchement pleural supérieur à 0,6 /L observe en cas d'épanchement néoplasiques
- E. Un taux d'ADA (Adénosine désaminase) < 40 U/L, représente une forte valeur prédictive négative de tuberculose.

Source : PROMO 2020**Réponse : BCE****3. Concernant L'exploration biochimique d'une pleurésie :**

- A. L'aspect séro-hémorragique du liquide de ponction permet d'évoquer pleurésie néoplasique
- B. En cas de tuberculose, le taux des protides est souvent inférieur à 50 g/
- C. Un quotient LDH pleurales/LDH plasmatiques <0,6 est en faveur d'un exsudat
- D. Les critères de Light sont surtout nécessaires en présence d'un liquide opaque.
- E. Le syndrome néphrotique peut être à l'origine d'un processus transudatif .

Source : PROMO 2019**Réponse : AE****4. A propos des liquides d'épanchement :**

- A. Leur concentration en protéines reste inchangée quel que soit l'étiologie
- B. Les exsudats sont d'origine inflammatoire et ont une concentration en protéines supérieure a 20g/l
- C. Les transsudats sont d'origine inflammatoire et ont une concentration en protéines inférieure a 20g/l
- D. L'acide hyaluronique est présent essentiellement dans le liquide synovial
- E. Leur concentration en glucose est identique a celle du plasma

Source : PROMO 2018**Réponse : BD****5. Le liquide pleural :**

- A. Est produit uniquement en pathologie
- B. Permet de lubrifier les deux feuillets pleuraux pariétale et viscérale
- E. Est résorbe grâce au drainage lymphatique
- D. Son aspect trouble est toujours en faveur d'un transsudat
- E. Possède une viscosité élevé

Source : PROMO 2018**Réponse : BC****6. Les différents liquides d'épanchement ont les caractéristiques suivantes :**

- A. Le liquide d'ascite est toujours purulent
- B. Le liquide synovial est essentiellement retrouvé dans le péritoine
- C. Leur concentration en enzymes est égale à celle du plasma
- D. Physiologiquement, ils ont un aspect limpide
- E. En pathologie, ils sont tous exsudatifs

Source : PROMO 2018**Réponse : D**

7. GAZOMETRIE/ SPIROMETRIE (9 QCM)

1. Concernant le prélèvement sanguin pour dosage des gaz du sang :

- A. A température ambiante, le délai entre le prélèvement et l'analyse ne doit pas dépasser 2 heures.
- B. Il doit être effectué en anaérobiose.
- C. L'anticoagulant utilisé est l'héparine
- D. le stress au cours du prélèvement peut altérer les résultats de la gazométrie
- E. La présence de bulles d'air dans le prélèvement sanguin entraîne une diminution de pCO_2 et une augmentation de pO_2 .

Source : PROMO 2022

Réponse : BCDE

2. A propos de l'acidose métabolique :

- A. Elle est due à une augmentation de production de base
- B. Le rapport $cHCO_3^-/cCO_2$ est bas
- C. Elle est compensée par une hypoventilation.
- D. La chlorémie est élevée dans l'acidose avec trou anionique élevé.
- E. L'acidose lactique est l'une des causes de l'acidose métabolique avec trou anionique normale

Source : PROMO 2022

Réponse : B

3. Cocher les réponses justes à propos d'un patient qui présente un pH à 7.32, une pCO_2 à 50mmHg et des bicarbonates à 32mmol/l sachant que les normes sont :

- PH (7.35-7.45)
- pCO_2 (35-45mmHg)
- HCO_3^- (22-28mmol/l)

- A. Il s'agit d'une alcalose métabolique.
- B. Il s'agit d'une acidose respiratoire.
- C. La compensation du trouble est partielle,
- D. L'organisme n'a pas encore commencé la compensation.
- E. La détresse respiratoire aiguë peut être la cause de ce trouble.

Source : PROMO 2022

Réponse : BCE

4. Quels paramètres définit l'état acidobasique d'un patient ?

- A. PH.
- B. pO_2 .
- C. pCO_2 .
- D. HCO_3^- .
- E. Sao_2 .

Source : P 2021 / P 2020

Réponse : ACD

5. Une diminution des bicarbonates sanguins s'observe au cours d'une :

- A. Acidose métabolique.
- B. Acidose respiratoire aiguë.
- C. Acidose respiratoire chronique.
- D. Alcalose métabolique.
- E. Alcalose respiratoire compensée.

Source : PROMO 2021

Réponse : AE

6. Une fois prélevé, quel est le délai maximal de conservation d'un prélèvement pour gaz du sang?

- A. 10 min
- B. 30 min
- C. 45 min
- D. 50 min
- E. 60 min

Source : PROMO 2019

Réponse : B

7. L'oxygène est transporté dans le sang sous deux formes, quel est le mode de transport le plus répandu ?

- A. Comme carboxyhémoglobine
- B. Dissous dans le liquide corporel
- C. Attache au dioxyde de carbone
- D. Comme oxyhémoglobine
- E. Fixe aux protéines plasmatiques

Source : PROMO 2018

Réponse : D

8. quelles sont les causes d'une diminution de la pO_2 :

- A. Nombre élevé de globules rouges
- B. Augmentation de la concentration d'hémoglobine
- C. Troubles au niveau du système nerveux central
- D. Augmentation des HCO_3^-
- E. Alvéoles défectueuses dans le poumon.

Source : PROMO 2018

Réponse : DE

9. Quelles sont les propositions vraies à propos de l'équilibre acido-basique ?

- A. Le CO_2 est la principale substance acide produite par l'organisme.
- B. L'hémoglobine ne participe pas au maintien de cet équilibre.
- C. Son exploration peut se faire sur sérum ou sang total.
- D. Une alcalose induit forcément une augmentation du pH sanguin.
- E. Les deux principaux organes régulateurs sont le rein et le poumon.

Source : PROMO 2018

Réponse : AE

RADIOLOGIE

1. PROPRIÉTÉS ET PRODUCTION DES RAYONS X (8 QCM)

1. Dans un tube à rayons X :

- A. Il règne un vide poussé
- B. Entre la cathode et l'anode règne une différence de potentiel de 40 à 150 kV
- C. Le courant de chauffage au niveau de la cathode permet la production d'électrons par effet thermo-ionique
- D. La production de rayons X repose sur un phénomène de freinage et un phénomène de collision
- E. La production des rayons X se fait au niveau de la cathode

Source : PROMO 2022

Réponse : ABCD

2. En traversant les tissus de l'organisme le faisceau RX (rayons X) subit une :

- A. Diffusion
- B. Diffraction
- C. Atténuation
- D. Cristallisation
- E. Absorption inégale selon la composition des structures à radiographier.

Source : PROMO 2021

Réponse : ABCE

3. Les rayons X sont :

- A. Ondes magnétiques
- B. Ondes paramagnétiques
- C. Ondes électriques
- D. Ondes électromagnétiques
- E. Ondes Gama

Source : PROMO 2020

Réponse : D

4. L'atome dans son état stable :

- A. est chargé Positivement
- B. est chargé Négativement
- C. sa charge est neutre
- D. la charge positive est supérieure à la charge négative
- E. Le nombre des neutrons égal au nombre des électrons

Source : PROMO 2019

Réponse : C

5. La radioactivité résulte de :

- A. Retour à la stabilité d'un atome excité
- B. Une excitation d'un atome sans retour à l'état stable
- C. Excitation du noyau seulement d'un atome
- D. Une libération des neutrons
- E. Transformation d'un atome avec émission de rayonnements.

Source : PROMO 2019

Réponse : AE

6. Les rayons X sont définis par :

- A. Sa longueur d'onde seule
- B. Sa fréquence seule
- C. Sa vitesse de propagation seule
- D. Sa fréquence, sa vitesse et la longueur d'onde
- E. Fréquence et vitesse de propagation

Source : PROMO 2019

Réponse : D

7. Le tube à rayon X permet :

- A. Élimination des rayons
- B. La production des rayons X
- C. Accélération des rayons X
- D. Formation de l'image radiologique
- E. Formation et élimination des rayons

Source : PROMO 2018

Réponse : B

8. La fréquence des rayons X varie entre :

- A. 30pétaHz-300 ExaHz
- B. 30hz-300Mhz*
- C. 30KHz-300GHz
- D. 30tetrahz-300tetrahz
- E. 300 ExaHz

Source : PROMO 2018

Réponse : A

2. DANGERS DES EXPLORATIONS RADIOLOGIQUES ET MOYENS DE PROTECTION (3 QCM)

1. Quelles propositions vraies caractérisent l'effet déterministe des rayonnements ionisants ?

- A. Il n'est pas caractéristique de l'irradiation.
- B. Il n'est pas gradué.
- C. Constants au-dessus d'un seuil
- D. Il est souvent tardif
- E. Il est plus intense si la dose reçue est plus élevée.

Source : PROMO 2022

Réponse : CE

2. Concernant l'irradiation partielle :

- A. La dose létale correspond à une dose de 6 à 10 Gy.
- B. Au-delà de 10 Gy, c'est le syndrome neurologique qui prédomine.
- C. L'effet de l'irradiation ne dépend pas de la région exposée et de la dose reçue.
- D. Les risques génétiques sont 3 fois moindres que les risques de cancer.
- E. Chez l'homme, une irradiation inférieure à 0,15GY est à l'origine d'une stérilité définitive.

Source : PROMO 2020**Réponse : D****3. Les effets pathologiques des rayonnements pour des doses élevées**

- A. Se produisent de façon aléatoire.
- B. sont caractéristiques de l'irradiation.
- C. Non gradués
- D. Les réactions tissulaires sont obligatoires si la dose reçue est inférieure à la dose seuil.
- E. Sont souvent tardifs

Source : PROMO 2018**Réponse : B****3. FORMATION DE L'IMAGE RADIOLOGIQUE (1 QCM)****1. les conditions techniques pour avoir un cliché thoracique de bonne qualité :**

- A. Cliché pris en expiration profonde.
- B. Courte distance tube-film
- C. Temps de pose longue
- D. Haute tension (120-140 kV)
- E. temps de pose le plus court possible.

Source : PROMO 2018**Réponse : DE****4. LES ULTRASONS- L'ECHOGRAPHIE THORACIQUE (7 QCM)****1. Concernant la sémilogie radiologique en échographie thoracique :**

- A. Le glissement pleural est un signe statique majeur de normalité.
- B. Le glissement pleural est un signe dynamique majeur de normalité.
- C. Le glissement pleural traduit la présence d'un épanchement pleural
- D. Le glissement pleural traduit la présence d'un pneumothorax
- E. Le signe de la « sinusoïde » est un signe dynamique normal

Source : PROMO 2022**Réponse : B****2. Concernant l'échographie thoracique :**

- A. L'échographie thoracique est un examen irradiant.
- B. Il n'y a pas d'allergie connue à cet examen.
- C. Les structures à contenu liquidien sont dépourvues d'échos et apparaîtront sur l'écran comme un vide d'échos (anéchoïque) ou noir sur l'écran.
- D. L'air apparaît anéchogène avec cône d'ombre impur
- E. Les sondes de basses fréquences permettent une étude fine à une faible profondeur

Source : PROMO 2022**Réponse : BC****3. A propos de l'échographie thoracique :**

- A. Les sondes de haute fréquence permettent une étude fine à une faible profondeur
- B. Le signe de la sinusoïde confirme la présence d'un pneumothorax.
- C. L'échographie thoracique est un examen de première intention en imagerie thoracique.
- D. L'échographie est une technique invasive.
- E. Les lignes horizontales appelé <<lignes A>> représentent le signe dynamique basique de normalité.

Source : PROMO 2021**Réponse : A****4. L'échographie thoracique :**

- A. En mode TM de l'échographie, le glissement pleural est un signe statique majeur de normalité.
- B. Un glissement pleural présent est en faveur de pneumothorax.
- C. Un glissement pleural présent permet d'éliminer formellement le pneumothorax.
- D. Le signe du bord de mer est en faveur de syndrome interstitiel.
- E. L'échographie est une technique non invasive mais irradiante pour l'organisme.

Source : PROMO 2020**Réponse : C****5. En échographie :**

- A. En mode TM, le glissement pleural est un signe dynamique, majeur de normalité.
- B. Un glissement pleural présent permet d'éliminer formellement le pneumothorax.
- C. Le signe du bord de mer est en faveur d'épanchement pleural
- D. L'échographie est une technique non invasive mais irradiante pour l'organisme
- E. Mode TM temps-mouvement représente la modification de position des structures mobiles.

Source : PROMO 2019**Réponse : ABE**

6. En échographie :

- A. Les structures à contenu liquidien sont d'aspect hyperéchogènes (blanc sur l'écran).
- B. Le signe du bord de mer est en faveur d'épanchement pleural
- C. En mode TM de l'échographie, le glissement pleural est un signe majeur de normalité.
- D. Un glissement pleural présent permet d'éliminer formellement le pneumothorax.
- E. Les calcifications sont anéchogènes (noir sur l'écran) suivies par une ombre acoustique.

Source : PROMO 2018**Réponse : CD****7. En échographie.**

- A. Les sondes de basses fréquences, permettent une étude à une grande profondeur
- B. Chaque écho reçu par la sonde est transformé en un signal électrique dont l'intensité varie en fonction des structures organiques rencontrées
- C. L'échographie thoracique est un examen de première intention en imagerie thoracique
- D. Les calcifications sont anéchogènes (noir sur l'écran) suivies par une ombre acoustique
- E. Les structures à contenu liquidien sont d'aspect hyperéchogènes (blanc sur l'écran)

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : AB**

5. PRINCIPES PHYSIQUES DE L'IRM / IRM THORACIQUE(5 QCM)

1. Concernant le signal en résonance magnétique :

- A. La relaxation T2 correspond au temps nécessaire à l'aimantation longitudinale pour récupérer 63% de sa valeur d'équilibre
- B. La relaxation T2 correspond au temps nécessaire à l'aimantation transversale pour récupérer 37% de sa valeur d'équilibre
- C. La relaxation T1 correspond au temps nécessaire à l'aimantation transversale pour récupérer 63% de sa valeur d'équilibre
- D. La relaxation T1 correspond au temps nécessaire à l'aimantation longitudinale pour récupérer 63% de sa valeur d'équilibre
- E. La relaxation T1 correspond au temps nécessaire à l'aimantation longitudinale pour récupérer 37% de sa valeur d'équilibre

Source : PROMO 2022**Réponse : BD****2. A propos de l'IRM thoracique :**

- A. La grossesse au 1er trimestre est une contre-indication absolue.
- B. L'IRM est un examen lent comparativement à la TDM.
- C. L'IRM a une meilleure résolution spatiale comparativement à la TDM
- D. L'IRM est peu irradiante comparativement à la TDM.
- E. Le produit de contraste utilisé en IRM est l'iode.

Source : PROMO 2021**Réponse : B****3. L'IRM thoracique :**

- A. Permet l'exploration à la fois du médiastin et du parenchyme pulmonaire.
- B. le signal de la graisse en IRM est en hypersignal T1, Hypersignal T2.
- C. Le signal de l'eau en IRM est en hypersignal T1, Hypersignal T2,
- D. L'IRM a un très bon contraste entre les tissus.
- E. L'IRM est une technique d'imagerie basée sur la résonance magnétique des protons d'oxygènes.

Source : PROMO 2019**Réponse : ABD****4. Imagerie par résonance Magnétique (IRM):**

- A. Moyen diagnostic moderne, invasif avec effets secondaires connus.
- B. Donne des images axiales natives avec reconstruction 3D.
- C. est basée sur les propriétés magnétiques de la matière.
- D. Se trouve dans les polycliniques.
- E. Est contre Indiqué chez la femme enceinte

Source : PROMO 2018**Réponse : BC****5. A propos de l'IRM thoracique :**

- A. L'IRM est une méthode irradiante donc contre indique chez la femme enceinte
- B. L'IRM permet de réaliser des acquisitions dynamiques.
- C. Le Gadolinium a un risque de fibrose néphrogénique systématique
- D. L'IRM est un examen rapide comparativement à la TDM
- E. Le parenchyme pulmonaire est riche en protons d'hydrogène ce qui constitue une limite à la réalisation d'IRM pulmonaire

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : BC**

6. TDM THORACIQUE (6 QCM)

1. La source de Rayons X du système d'acquisition du scanner comporte :

- A. Un générateur.
- B. Une photodiode
- C. Un tube à RX
- D. Un système de visualisation
- E. Une collimation.

Source : PROMO 2022

Réponse : ACE

2. La Tomodensitométrie est :

- A. Une technique de tomographie utilisant les rayon X
- B. Une technique d'imagerie médicale qui utilise les ultrasons
- C. Une technique non invasive et non irradiante
- D. Une technique d'analyse quantitative des densités élémentaires d'une structure à partir de l'atténuation des rayons X
- E. Une technique d'imagerie médicale qui utilise des ondes de radiofréquence

Source : PROMO 2021

Réponse : AD

3. La TDM thoracique :

- A. La tomodensitométrie est un examen très lent avec une résolution spatiale de mauvaise qualité.
- B. Possède trois systèmes : Aquisition; traitement et visualisation
- C. Utilise les rayons Gama
- D. Utilise les rayons magnétiques
- E. Utilise les ultra son

Source : PROMO 2020

Réponse : B

4. La TDM thoracique :

- A. La tomodensitométrie est un examen très rapide avec une résolution spatiale d'excellente qualité.
- B. Possède trois systèmes : Aquisition ; traitement et visualisation
- C. Utilise les rayons X
- D. Utilise les rayons électromagnétiques visibles à l'œil nus.
- E. Utilise les ultra son

Source : PROMO 2019

Réponse : ABC

5. Le scanographe (scanner):

- A. Utilise les ondes magnétiques
- B. Se compose de trois systèmes : d'acquisition, de traitement et de visualisation.
- E. Un photomultiplicateur qui amplifie les cristaux de sodium.
- D. Utilise les ultrasons .
- E. Utilise les ions H+

Source : PROMO 2018

Réponse : B

6. Les critères de malignité d'un nodule pulmonaire

- A. Taille est égale ou moins de 1cm
- B. Consistance liquide ou semi-liquide
- C. Contours spéculés et irréguliers
- D. Plage graisseuse
- E. Ganglion intra pulmonaire

Source : PROMO 2018

Réponse : C

7. LES PRODUITS DE CONTRASTE EN IMAGERIE (2 QCM)

1. Concernant les produits de contraste gadolinés :

- A. Ils ont une élimination urinaire.
- B. Ils peuvent traverser la barrière hémato encéphalique à l'état physiologique.
- C. Ils peuvent être allergisants.
- D. Ils sont utilisés en tomodensitométrie et en imagerie par résonance magnétique
- E. Ils ne passent pas dans le lait maternel.

Source : PROMO 2022

Réponse : AC

2. Quelles sont les voies d'administration des produits de contraste en imagerie ?

- A. Par voie intra veineuse.
- B. Par inhalation.
- C. Par voie intra artérielle.
- D. Per os
- E. Par voie sous cutanée

Source : PROMO 2021

Réponse : ACD

8. RADIOGRAPHIE STANDARD THORACIQUE ET RADIOANATOMIE NORMALE DU CŒUR (12 QCM)

1. Concernant l'Index Cardio-Thoracique :

- A. C'est le rapport du plus petit diamètre cardiaque sur le diamètre thoracique
- B. Il est calculé sur une radiographie thoracique de face
- C. Il est calculé sur une radiographie thoracique de profil
- D. Il est normal s'il est supérieur à 0.5
- E. S'il est inférieur à 0.5 c'est en faveur d'une cardiomégalie

Source : PROMO 2022

Réponse : B

2. Concernant la radiographie thoracique de profil:

- A. Le profil gauche est reconnu par les coupes diaphragmatiques qui se croisent
- B. Le profil droit est reconnu par les coupes diaphragmatiques qui se croisent
- C. Il y a trois espaces clairs à analyser à savoir l'espace retro sternal, retro cardiaque et retro trachéal.
- D. Lors d'une bonne inspiration les culs de sac postérieurs sont bien distingués.
- E. L'acquisition de référence est faite en expiration

Source : PROMO 2022**Réponse : ACD****3. A propos de la Radiographie thoracique :**

- A. Elle est indiquée dans la recherche d'une pleurésie.
- B. Elle est indiquée dans la recherche d'un pneumothorax.
- C. Elle est indiquée dans la recherche d'une pneumopathie
- D. Elle est indiquée dans la recherche d'une ascite.
- E. Elle est indiquée dans la cadre des pathologies pulmonaires professionnelles.

Source : PROMO 2021**Réponse : ABCE****4. La Radiographie thoracique :**

- A. une bonne symétrie est nécessaire à l'interprétation.
- B. Elle doit être prise avec une bonne expiration.
- C. L'index cardio-thoracique doit être supérieur à 0,5
- D. Un cliché en bonne inspiration permet la visualisation de 5-6 cotes postérieures.
- E. La radiographie de profil est faite côté droit du patient contre la plaque.

Source : PROMO 2020**Réponse : A****5. La Radiographie thoracique :**

- A. Une incidence antéropostérieure va créer une fausse cardiomégalie.
- B. le malade doit être en expiration
- C. Le hile gauche doit être toujours inférieur au hile droit.
- D. le diaphragme gauche doit être supérieur au droit.
- E. L'incidence est antéropostérieure.

Source : PROMO 2020**Réponse : A****6. La radiographie simple du cœur :**

- A. Se fait toujours en position couchée
- B. Nécessite l'injection du produit de contraste
- C. Réalisée avec une incidence postéro antérieure
- D. Sa normalité élimine toute pathologie cardiovasculaire
- E. Sa normalité élimine le diagnostic de l'angine de poitrine

Source : PROMO 2019**Réponse : C****7. La Radiographie thoracique :**

- A. Une Incidence Antéro-postérieure va créer une fausse cardiomégalie.
- B. Une mauvaise Inspiration peut simuler un élargissement du cœur
- C. Le hile gauche doit être toujours Inferieur au hile droit.
- D. La vascularisation pulmonaire s'arrête généralement au contact de la plèvre.
- E. Chez un patient alité l'incidence est antéro-postérieure habituellement.

Source : PROMO 2019**Réponse : ABE****8. Sur un Téléthorax de face ; la scissure horizontale :**

- A. Appelée aussi petite scissure.
- B. Appelée aussi grande scissure
- C. Sépare le lobe supérieur droit et le lobe moyen droit.
- D. Sépare le lobe supérieur droit et le lobe inférieur droit.
- E. Une anomalie de position de cette scissure permet de suspecter une pathologie adjacente.

Source : PROMO 2019**Réponse : ACE****9. Sur une radiographie du cœur de face :**

- A. L'arc moyen gauche correspond à l'artère pulmonaire
- B. le bord droit est un bord artériel
- C. le bord gauche est fait deux arcs et le bord droit est fait de 03 arcs
- D. l'arc supérieur droit correspond à la veine cave inferieure.
- E. l'arc inferieur droit correspond à l'oreillette gauche

Source : PROMO 2018**Réponse : A**

10. Concernant l'hypertrophie de l'oreillette gauche :

- A. Donne une image de double contour de l'arc inférieur gauche
- B. Donne un allongement de l'arc inférieur droit
- C. soulève la pointe du Cœur du diaphragme
- D. Peut donner un dédoublement de l'arc moyen gauche
- E. Peut entraîner une ouverture de la carene.

Source : PROMO 2018**Réponse : DE****11. Concernant l'oreillette gauche sur une radiographie simple :**

- A. Tous ses bords sont toujours visibles.
- B. Elle constitue le bord droit du médiastin.
- C. Elle participe à la formation de majeure partie de l'arc moyen gauche
- D. peut participer à la formation de l'arc moyen gauche.
- E. Elle participe à la formation de l'arc inférieur gauche.

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : D****12. Radiographie thoracique de profil :**

- A. Elle est faite côté droit du patient contre la plaque.
- B. Elle ne permet pas de préciser le siège de l'anomalie détectée sur la radiographie de face.
- C. Il faut toujours rechercher les deux espaces clairs : le rétro-sternal et le rétro-cardiaque.
- D. l'incidence des rayons X est gauche-droite.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : C****9. Les principales techniques d'explorations cardiovasculaires et leurs indications (3 QCM)****1. En imagerie cardiaque :**

- A. La TDM est l'examen de référence pour l'exploration des vaisseaux de gros calibre.
- B. L'angiographie est une technique non invasive.
- C. Le coroscaner se fait avec synchronisation à l'ECG.
- D. La synchronisation à l'ECG est indispensable pour les explorations du cœur et des gros vaisseaux en IRM.
- E. La radiographie thoracique standard n'a pas d'indication dans l'évaluation de l'œdème aigu du poumon (OAP).

Source : PROMO 2021**Réponse : ACD****2. Le Coro-scanner :**

- A. Est un Angio-scanner explorant les artères coronaires.
- B. Nécessite une synchronisation avec l'ECG
- C. Ne nécessitant pas l'injection de produit de contraste
- D. Nécessitant une injection intra artérielle de produit de contraste iodée
- E. Présente un double but ; diagnostique et thérapeutique.

Source : PROMO 2019**Réponse : AB****3. L'Angioscanner thoracique :**

- A. Est un examen ne nécessitant pas l'injection de produit de contraste iodée
- B. Nécessite l'introduction d'un cathéter par voie artérielle au niveau des cavités cardiaques.
- C. Est un examen à base de rayon X
- D. Est un examen qui explore les vaisseaux du thorax.
- E. Est un examen à base de rayon Gamma.

Source : RATRAPAGE 2022**Réponse : CD****10. SYNDROME ALVEOLAIRE (4 QCM)****1. Concernant le syndrome alvéolaire :**

- A. C'est la traduction radiologique de la présence d'air dans la cavité pleurale.
- B. Se traduit par une hyperclarté pulmonaire diffuse avasculaire
- C. Le bronchogramme aérique est un signe caractéristique
- D. se présente sous la forme d'une opacité effaçant les structures vasculaires
- E. L'évolution est lente

Source : PROMO 2022**Réponse : CD****2. Le syndrome de comblement alvéolaire se caractérise par :**

- A. Une clarté systématisée.
- B. Une condensation hétérogène par la présence d'un bronchogramme aérique.
- C. Refoulement des éléments du médiastin
- D. Réduction du volume pulmonaire
- E. Déplacement de la trachée.

Source : P 2021 / P 2020**Réponse : B**

3. L'affection pouvant entraîner un bronchogramme aérique :

- A. Tuberculose
- B. Pleurésie
- C. Lipome de la paroi thoracique
- D. Epanchement pleurale
- E. Pneumothorax

Source : PROMO 2020

Réponse : A

4. La confluence au cours d'une pneumonie est expliquée par :

- A. Atteinte de proche en proche des groupes alvéolaires via les canaux de Lambert et Martin
- B. Un groupe alvéolaire affecte un autre groupe plus loin via les pores de Kohn.
- C. Un groupe alvéolaire affecte un autre groupe plus loin via les canaux de Lambert et Martin
- D. Atteinte de proche en proche des groupes alvéolaires via les pores de Kohn.
- E. Les pores de Kohn comme les canaux de Lambert et Martin font communiquer les alvéoles du même acinus

Source : PROMO 2018

Réponse : CD

11. SYNDROME MEDIASTINAL (3 QCM)

1. Les caractères d'une opacité médiastinale :

- A. Densité hydrique, le plus souvent homogène
- B. Limite externe floue et continue, concave vers le poumon.
- C. Le raccordement de cette opacité se fait en pente douce avec les bords du médiastin.
- D. Sa limite interne est bien visible dans le médiastin.
- E. Le raccordement de cette opacité se fait en pente abrupte avec les bords du médiastin.

Source : PROMO 2022

Réponse : AC

2. Le signe de la silhouette :

- A. Deux opacités situées dans le même plan, elles effacent leurs contours.
- B. Deux opacités situées dans le même plan, elles conservent leurs contours.
- C. Le plan de référence étant le cœur, une opacité qui efface le contour est située dans un plan différent.
- D. Le bord externe de l'opacité n'est pas visible au-dessus de la clavicule.
- E. Les vaisseaux restent visibles à travers une opacité hilare.

Source : P 21 / P 20 / P 19

Réponse : A

3. Dans le syndrome médiastinal, une opacité :

- A. qui efface le plan du Cœur est situé dans le même plan que celui-ci
- B. qui n'efface pas le bord du Cœur est située dans un plan différent de celui-ci
- C. Dont le bord externe est visible au-dessus de la clavicule est antérieure
- D. Dont le bord externe n'est pas visible au-dessus de la clavicule est postérieure
- E. Dont le contour externe traverse le diaphragme est médiastinale supérieure

Source : PROMO 2018

Réponse : AB

12. SYNDROME PLEURAL / SYNDROME PARIETAL (5 QCM)

1. Concernant le syndrome pleural :

- A. La tumeur fantôme est l'épanchement pleural scissural.
- B. Un épanchement pleural aérique se traduit par une hyperclarté traversée par les structures vasculaires
- C. Une TDM pulmonaire permet de mieux visualiser un épanchement pleural aérique de minime abondance
- D. Une exagération de la distance entre la poche à air gastrique et le parenchyme pulmonaire, est en faveur d'un épanchement pleural liquidien scissural
- E. Le signe de José Remy permet de différencier un hydropneumothorax d'un abcès pulmonaire.

Source : PROMO 2022

Réponse : ACE

2. L'épanchement pleural liquidien de grande abondance se traduit par :

- A. Hyperclarté vascularisée pulmonaire
- B. Opacité pulmonaire rétractile
- C. Opacité refoulant le médiastin vers le côté opposé
- D. Attraction des éléments du médiastin
- E. Peut être visualisé en échographie en mode B et TM

Source : PROMO 2021

Réponse : CE

3. L'épanchement pleural liquidien libre de moyenne abondance sur un Téléthorax :

- A. Hémothorax radio-opaque.
- B. Refoule les éléments du médiastin.
- C. Limite supérieure concave en dehors et en bas.
- D. Efface la coupole diaphragmatique.
- E. Contenant un bronchogramme aérique.

Source : PROMO 2020

Réponse : D

4. Sur un cliché de face, l'épanchement pleural liquidien libre de Moyenne abondance se traduit :

- A. Opacité hétérogène
- B. De limite supérieure concave en haut et en dehors
- C. Effacement du couple diaphragmatique
- D. Comblement du cul-de-sac costodiaphragmatique
- E. Réalisé à l'hémothorax opaque

Source : PROMO 2018**Réponse : CD****5. Sur un cliché de face, un épanchement sous-pulmonaire gauche se manifeste :**

- A. Le Sommet de la pseudo-coupole diaphragmatique est plus interne qu'une coupole normale.
- B. Image de pseudo-coupole diaphragmatique
- C. Eloignement de la poche à air gastrique de plus de 1,5 cm de la pseudo-coupole diaphragmatique
- D. De limite supérieure concave en haut et en dedans (Ligne de Demoiseau)
- E. Raccordement en pente douce avec la paroi thoracique

Source : PROMO 2018**Réponse : BC**

13. SYNDROME BRONCHIQUE (2 QCM)

1. A propos du syndrome bronchique :

- A. Les bronchectasies cylindriques sont les plus rares.
- B. Les bronchectasies kystiques peuvent contenir des niveaux hydro-aériques
- C. L'image en cocarde traduit une dilatation bronchique de type kystique.
- D. Dans la classification de Reid, les bronchectasies cylindriques se traduisent par l'alternance de sténoses et de dilatations bronchiques.
- E. L'image en rail est en faveur d'un épaissement bronchique ou une dilatation bronchique de type cylindrique.

Source : PROMO 2021**Réponse : BE****2. Le syndrome bronchique :**

- A. Une radiographie thoracique est systématiquement indiquée lors d'une crise d'asthme.
- B. L'aspect de « trachée en lame de sabre » est en faveur de BPCO.
- C. Les impactions mucoïdes se traduisent par des clartés arrondies ou polyédriques.
- D. L'aspect de « poumon sale » en radiographie standard traduit la présence d'emphysème pulmonaire.
- E. L'atélectasie se traduit par une hyperclarté bien visible sur les clichés en expiration.

Source : PROMO 2020**Réponse : B**

14. SYNDROME CAVITAIRE (1 QCM)

1. Une aspergillose se traduit par :

- A. Une condensation parenchymateuse triangulaire.
- B. Une image cavitare avec niveau hydro-aérique.
- C. Une formation kystique de parois fines et régulières.
- D. Une image en grelot.
- E. Une image en nénuphar.

Source : PROMO 2021**Réponse : D**